الدليل التنفيذي لترخيص وإنشاء وتشغيل
مستشفى خاص في المملكة الأردنية الهاشمية

من اختيار الموقع والتخطيط الهندسي حتى إذن المباشرة والتشغيل المستمر

المملكة الأردنية الهاشمية	النطاق الجغرافي
تحقق تشريعي حتى 26 أيلول 2026	المرجع الزمني
دليل تنفيذي/مصفوفة امتثال قبل التصميم والبناء والتشغيل	نوع الوثيقة
إصدار 1.0 — للاستخدام في إعداد ملف الترخيص والتنسيق مع الجهات	حالة الوثيقة
العربية — محاذاة من اليمين إلى اليسار — متن Arial قياس 12	لغة وتنسيق

وثيقة عملية: كل شرط رقمي وُسم بمرجعه، وكل متطلب يحتاج اعتماداً كودياً أو خطياً تم تمييزه صراحة.

ضبط الوثيقة وحدود استخدامها

الغرض من هذا الدليل هو تحويل التشريعات والخدمات الحكومية المنشورة إلى مسار عمل قابل للتنفيذ لفريق المالك والاستشاري والمقاول ومشغّل المستشفى. وهو لا يحل محل النسخة الرسمية من الجريدة الرسمية أو المخططات المختومة أو الموافقات الخطية الصادرة للمشروع نفسه؛ وعند التعارض تكون الأولوية للنص النافذ وللشرط الأشد الذي تعتمده الجهة المختصة.

> قاعدة الدقة المعتمدة في هذا التقرير
>
> لم تُدرج أي قيمة رقمية على أنها شرط ترخيص إلا إذا أمكن إسنادها إلى نظام أو تعليمات أو دليل خدمة حكومي منشور. القيم التي تعتمد على إشغال المبنى، سعة الإخلاء، نوع الجهاز أو مستوى الخدمة تُترك للحساب الكودي وللاعتماد الخطي من الجهة المختصة.

الرمز	المعنى	طريقة التعامل
[م]	متطلب ملزم منصوص عليه صراحة	يُدرج في أساس التصميم وقائمة التحقق ولا يُعدّل إلا بنص نافذ أو موافقة رسمية.
[ا]	متطلب يعتمد على موافقة جهة/لجنة أو كود	يُطلب له كتاب أو مخطط مختوم قبل تجميد التصميم وقبل التوريد.
[ت]	توصية تنفيذية لإدارة المخاطر	ليست رقماً ترخيصياً بذاتها؛ تُستخدم لمنع إعادة التصميم أو رفض الكشف.
[ح]	نقطة تحتاج تحديثاً قبل التقديم	يُعاد التحقق منها من الجريدة الرسمية والبوابة الحكومية في تاريخ الطلب.

تاريخ القطع المرجعي: 2026/09/26. لا تعتمد مسودة تشريع أو خبراً صحفياً بديلاً عن النشر في الجريدة الرسمية. يجب إعادة التحقق عند التقديم، وعند كل تعديل لنطاق الأسرة أو الأقسام أو الموقع أو الملكية.

الفهرس

يُحدَّث الفهرس تلقائياً عند فتح الملف في Word (انقر بزر الفأرة الأيمن واختر تحديث الحقل).

> ملاحظة فنية
>
> يفتح الملف في Microsoft Word مع تفعيل تحديث الحقول ليظهر الفهرس بأرقام الصفحات. عند الطباعة النهائية: زر الفأرة الأيمن داخل الفهرس ← تحديث الحقل ← تحديث الجدول بالكامل.

دليل الفصول (1)	دليل الفصول (2)
1. الخلاصة التنفيذية	13. الحوكمة واللجان
2. الإطار التشريعي والتحديثات	14. الاختبارات والتشغيل التجريبي
3. خريطة الجهات الحكومية	15. إذن الأشغال والترخيص النهائي
4. المراحل التنفيذية	16. الالتزامات بعد التشغيل
5. ملف وزارة الصحة	17. قائمة التحقق الرئيسية
6. المتطلبات المعمارية والإنشائية	18. الأخطاء عالية الخطورة
7. متطلبات الأقسام	19. البرنامج الزمني

دليل الفصول (1)	دليل الفصول (2)
8. الوحدات التخصصية	20. توزيع المسؤوليات
9. المتطلبات الهندسية	21. سجل التحديثات
10. الدفاع المدني	22. المراجع الرسمية
11. البيئة والنفايات والصرف	23. نماذج العمل
12. العمل والكوادر والضمان	

1. الخلاصة التنفيذية

ترخيص المستشفى الخاص في الأردن ليس معاملة واحدة؛ إنه سلسلة اعتمادات مترابطة. تبدأ من أهلية المالك واختيار الموقع، ثم موافقة وزارة الصحة المبدئية على المخططات، ثم التنظيم ورخصة البناء وتدقيق الدفاع المدني والكودات، ثم الإنشاء والكشف وإذن الأشغال، ثم تراخيص الأقسام والكوادر والتجهيزات، وتنتهي بالموافقة النهائية وإذن مباشرة العمل من وزير الصحة. لا يجوز تشغيل المستشفى قبل اكتمال المرحلتين الأخيرتين [ص-01][ص-02].

القرار التنفيذي الأهم

لا تُشترَ الأرض ولا يُجمَّد المخطط المعماري قبل اجتماع تنسيقي موثق مع مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية، والجهة التنظيمية المختصة، والدفاع المدني. السبب أن موافقة وزارة الصحة المبدئية مدتها خمس سنوات، وتُلغى تلقائياً إذا لم يكتمل الإنشاء خلالها، كما أن النسخة النهائية من المخططات المقدمة للوزارة يجب أن تحمل موافقة الأمانة/البلدية والدفاع المدني قبل الكشف الموقعي.

المحور	الحكم التنفيذي المختصر	المرجع
نوع المستشفى	عام: 40 سريراً على الأقل مع الجراحة والنسائية والتوليد والباطني والأطفال. متخصص: 20 سريراً على الأقل. مستشفى الأسنان المتخصص: 10 أسرّة على الأقل بموافقة الوزير.	[ص-01][ص-02]
الموافقة المبدئية	صالحة خمس سنوات؛ تُلغى تلقائياً إذا لم يكتمل الإنشاء ضمن المدة.	[ص-02]
بدء العمل	ممنوع قبل الموافقة النهائية على الترخيص وصدور إذن مباشرة العمل من الوزير.	[ص-01]
الرسوم الأساسية	أول ترخيص: 100 دينار/سرير. التجديد كل خمس سنوات: 75 ديناراً/سرير وفق تعديل 2022؛ توجد حوافز خصم 25% في الحالات المحددة بالنظام.	[ص-02][ص-03]
غرف العمليات	غرفتان على الأقل + تحضير + إفاقة + غرفتا غيار للعاملين + استراحة. الارتفاع الإنشائي 3.50 م والسقف المستعار 3.00 م على الأقل. لا ينص النظام المنشور على مساحة أرضية موحدة لغرفة العمليات.	[ص-02]
الممرات	العرض الأدنى العام داخل المستشفى 2.40 م، مع تطبيق أي عرض أشد ينتج عن حسابات الإخلاء وكود الوقاية من الحريق.	[ص-01][ب-01]
المياه والمواقف	خزن مياه لا يقل عن 250 م³؛ ومواقف مجانية لا تقل عن موقف لكل سرير إضافة إلى موقف لكل 100 م² من مساحة المبنى، مع الالتزام أيضاً بالتنظيم المحلي إن كان أشد.	[ص-02][ب-02]

المحور	الحكم التنفيذي المختصر	المرجع
الرقمنة	ملف طبي إلكتروني لكل مريض داخلي؛ نص تعديل 2022 على تحويل الملفات الورقية إلى إلكترونية خلال خمس سنوات من نفاذه؛ الموعد الحرج عملياً 2027/11/16 ما لم يصدر تعديل لاحق.	[ص-02]

1.1 المسار الحرج المختصر

1. تحديد نموذج الملكية ونوع المستشفى وسعته وخدماته ووحداته التخصصية؛ ثم تسجيل الشركة/المؤسسة إن لزم.
2. فحص الأرض تنظيمياً وقانونياً وبيئياً ووظيفياً: الاستعمال، القيود، الارتدادات، الوصول، الصرف الصحي، القدرة الكهربائية، مسار الإسعاف، وإمكانية تحقيق المواقف.
3. إعداد برنامج طبي وظيفي ومخططات مفهوم أولية وإيداع طلب وزارة الصحة بالمرفقات الأساسية.
4. استلام ملاحظات لجنة المستشفيات الخاصة وتعديل المخططات حتى صدور الموافقة المبدئية.
5. تطوير المخططات لدى مكاتب هندسية مرخصة وتدقيقها لدى نقابة المهندسين ومجلس البناء الوطني والجهة التنظيمية والدفاع المدني والبيئة حسب الاختصاص.
6. إصدار رخصة البناء وتنفيذ الأعمال تحت الإشراف، مع إدارة أي تعديل كتابياً قبل التنفيذ.
7. إجراء اختبارات القبول والتشغيل التجريبي للأنظمة الطبية والهندسية، وإقفال ملاحظات الدفاع المدني وإصدار إذن الأشغال.
8. استكمال تراخيص الصيدلية والمختبر والأشعة والوحدات التخصصية وسيارات الإسعاف والكوادر ومزاولات المهن.
9. تقديم طلب الجاهزية للكشف النهائي لوزارة الصحة، دفع الرسوم، استلام الترخيص، ثم استلام إذن مباشرة العمل.
10. تشغيل نظام امتثال مستمر: تجديد خمس سنوات، قوائم العاملين كل ستة أشهر، أسعار معتمدة، ملفات إلكترونية، نفايات، سلامة مهنية، صيانة واختبارات دورية.

2. الإطار التشريعي والتحديثات النافذة

يجب قراءة نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014 مع تعديلاته كنص واحد. المرجع الحاكم حالياً هو النظام الأصلي المنشور في العدد 5286 من الجريدة الرسمية، مع نظام التعديل رقم 63 لسنة 2022 المنشور في العدد 5825 بتاريخ 2022/11/16، إضافة إلى التعليمات القطاعية الصادرة بمقتضاه [ص-01][ص-02].

التشريع/المرجع	الحالة حتى 2026/09/26	الأثر المباشر على المشروع
قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته	نافذ	السند الأعلى لترخيص مؤسسات الرعاية الصحية والرقابة والعقوبات.
نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014	نافذ مع التعديلات	شروط المالك، السعة، التصميم، الأقسام الإلزامية، التشغيل، اللجان، الرسوم.
نظام معدل رقم 63 لسنة 2022	نافذ منذ النشر 2022/11/16	مدة الموافقة خمس سنوات، تحديث المبنى والأقسام والرسوم والسجلات الإلكترونية والمركبات والاحتياطيات.
دليل خدمات وزارة الصحة، الإصدار الثاني 2026	دليل إجرائي رسمي	قنوات التقديم، الوثائق والخطوات والرسوم الإجرائية الحالية؛ لا يعلو على النظام.
تعليمات وحدات قسطرة القلب والأوعية رقم 1 لسنة 2018	تعليمات تخصصية	موافقة مستقلة قبل إنشاء/تشغيل وحدة القسطرة.
تعليمات تفتيت الحصى رقم 3 لسنة 2019	تعليمات تخصصية	موافقة مستقلة؛ ورد بدل إضافة الوحدة 1,000 دينار بدليل 2026.

التشريع/المرجع	الحالة حتى 2026/09/26	الأثر المباشر على المشروع
تعليمات تنظير الجهاز الهضمي رقم 4 لسنة 2019	تعليمات تخصصية	موافقة مستقلة؛ ورد بدل إضافة الوحدة 1,000 دينار بدليل 2026.
تعليمات إنشاء وحدات غسيل الكلى لدى المستشفيات الخاصة لسنة 2024	منشورة بالعدد 5930	تُطبق على تصميم الوحدة وكادرها وتشغيلها، ولا يكفي ترخيص المستشفى العام.
تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب/أطفال الأنابيب لسنة 2024	منشورة بالعدد 5954	موافقة مستقلة واشتراطات مكانية وتجهيزية وكادرية وسجلات خاصة.
تعليمات إدارة النفايات الطبية لسنة 2024	نافذة وتلغي تعليمات 2001	الفرز، الألوان، التخزين، النقل، المعالجة، السجلات والتقارير.
قانون البناء الوطني رقم 7 لسنة 1993 وتعديلاته والكودات	نافذ	التصميم والتدقيق والتنفيذ والفحص وفق الكودات الوطنية والجهات المخولة.
نظام الأبنية والتنظيم داخل عمّان رقم 28 لسنة 2018 وتعديلاته، ومنها رقم 13 لسنة 2025، ونظام التخطيط والتنظيم رقم 81 لسنة 2025	نافذ داخل أمانة عمّان	الاستعمال والارتدادات والارتفاعات والمواقف ورخصة البناء وإذن الأشغال.
نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم 1 لسنة 2022	نافذ خارج نطاق أمانة عمّان، بحسب الاختصاص	التنظيم ورخص البناء وإذن الأشغال لدى البلدية/اللجنة المختصة.
نظام التصنيف والترخيص البيئي رقم 69 لسنة 2020 وتعديلاته	نافذ	قرار التصنيف/الموافقة البيئية قبل التنفيذ؛ نطاق الدراسة تحدده وزارة البيئة.
أنظمة السلامة والصحة المهنية 31 و32 و33 لسنة 2023	نافذة	تقييم المخاطر، المشرفون واللجان، الرعاية الطبية للعاملين وإجراءات السلامة.

تنبيه بشأن المسودات

خلال 2026 ظهرت مواد تشاور/تحديثات على ملاحق نظام التصنيف والترخيص البيئي. لا تُعامل أي مسودة على أنها نافذة قبل التحقق من نشرها في الجريدة الرسمية. يطلب المشروع قرار تصنيف بيئي مكتوباً باسم الموقع والنطاق الفعلي، خصوصاً إذا شمل محرقة، محطة معالجة، تخزين وقود/غازات، طباً نووياً أو علاجاً إشعاعياً.

2.1 أهم الفروق التي أحدثها تعديل 2022

الموضوع	الوضع التنفيذي الحالي	إجراء الفريق
مدة الموافقة المبدئية	خمس سنوات، لا ثلاث سنوات؛ الإلغاء تلقائي إن لم يكتمل الإنشاء.	إنشاء سجل تاريخ بدء/انتهاء واعتماد برنامج زمني بهامش لا يقل عن 9 أشهر قبل الانتهاء.
المخططات	النسخة النهائية المقدمة للصحة تحمل موافقة الأمانة/البلدية والدفاع المدني قبل الكشف.	عدم طلب الكشف النهائي بمخططات غير مختومة أو غير مطابقة للمنفذ.

الموضوع	الوضع التنفيذي الحالي	إجراء الفريق
ارتفاع العمليات	3.50 م من البلاط إلى أسفل السقف/الجسر؛ وإذا وجد سقف مستعار فلا يقل الصافي عنه عن 3.00 م.	تنسيق الأعماق الإنشائية ومجاري الهواء والبندنتات قبل تثبيت منسوب الطوابق.
ارتفاع الحمامات	2.40 م كحد أدنى.	منع تعارض شبكات الصرف/التهوية مع الصافي.
العناية الحثيثة	4 أسرّة للعام و2 للمتخصص مع سرير عزل واحد.	تصميم العزل وضغطه وخدماته وفق برنامج معتمد، وليس مجرد تخصيص سرير بالاسم.
الإسعاف	سيارتان حتى 100 سرير، إحداهما متاحة 7/24؛ وسيارة إضافية لكل 100 سرير إضافية.	اعتماد موقف ومسار وتجهيز وتشغيل وسيارات مرخصة.
المشرحة	حجرة تبريد واحدة على الأقل لكل 50 سريراً.	احتساب التقريب للأعلى وتحديد حركة الجثمان بعيداً عن الجمهور والغذاء.
الهندسة الطبية	مهندس أجهزة طبية للمستشفى الذي تزيد سعته على 100 سرير.	التوظيف قبل الجاهزية وإعداد برنامج الصيانة والمعايرة.
القوائم الوظيفية	ترسل للوزارة كل ستة أشهر.	تقويم امتثال نصف سنوي ومسؤول محدد.
السجل الطبي	إلكتروني؛ تحويل الورقي خلال خمس سنوات من نفاذ التعديل.	خطة إقفال قبل 2027/11/16 ما لم يتغير النص، مع حماية ونسخ احتياطي واسترجاع.
التجديد	كل خمس سنوات، 75 ديناراً لكل سرير؛ 25% حسم في الحالات المحددة.	حفظ أدلة الاعتماد/خلو الإنذارات والتحضير قبل 6 أشهر.

3. خريطة الجهات الحكومية ومسؤولياتها

الجهة	الموافقة/المخرج	متى تُراجع
وزارة الصحة — مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية	موافقة مبدئية، اعتماد المخططات من منظور النظام، كشف، ترخيص نهائي، إذن مباشرة العمل، موافقات الوحدات التخصصية.	من مرحلة البرنامج الطبي وحتى ما بعد التشغيل.
لجنة المستشفيات الخاصة	دراسة الطلبات والمخططات، الكشف، التوصية، الشكاوى، إضافة الوحدات والخدمات.	عند التأسيس، التعديل، الزيادة، النقل والكشف.
أمانة عمّان الكبرى أو البلدية/اللجنة التنظيمية	مخطط موقع وتنظيم، موافقة استعمال، رخصة بناء، تدقيق مطابقة، إذن أشغال، رخصة مهن/نشاط بحسب النظام المحلي.	قبل شراء الموقع، قبل البناء، وبعد الإنجاز.
نقابة المهندسين الأردنيين	تدقيق/اعتماد المخططات وحسابات الاختصاصات وفق الصلاحيات والكودات.	مرحلة التصميم التفصيلي وقبل رخصة البناء.
مجلس البناء الوطني/الجهات المخولة	تطبيق قانون البناء الوطني والكودات والتفتيش وضبط الجودة.	التصميم والتنفيذ والاستلام.

الجهة	الموافقة/المخرج	متى تُراجع
مديرية الأمن العام — الدفاع المدني	تدقيق مخططات الوقاية والحماية الذاتية، كشف أنظمة الحريق، توصية لإذن الأشغال ورخص المهن.	من المفهوم المبكر حتى الاستلام والتجديد.
وزارة البيئة	قرار تصنيف/ترخيص بيئي وشروط إدارة التأثيرات والنفايات الخطرة، بحسب نطاق المشروع.	قبل رخصة البناء/الإنشاء وقبل أي مرفق معالجة أو تخزين خاص.
وزارة الصحة — صحة البيئة	موقع المشروع من الناحية الصحية والبيئية، النفايات الطبية، المياه والصرف، الرقابة.	الاختيار، الإنشاء، التشغيل.
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن	ترخيص مؤسسي وشخصي للممارسات الإشعاعية، موافقات المصادر والأجهزة والاستيراد والنقل والتخزين والتخلص.	قبل تصميم التدريع وقبل شراء/استيراد الجهاز وقبل التشغيل.
وزارة العمل	سلامة وصحة مهنية، لجان ومشرفون، تصاريح غير الأردنيين، التفتيش.	قبل التوظيف والتشغيل وبشكل مستمر.
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي	شمول المنشأة والعاملين والالتزامات التأمينية.	قبل بدء علاقات العمل.
دائرة مراقبة الشركات/وزارة الصناعة والتجارة	تسجيل الكيان والغايات والشهادات.	أول المشروع وعند تغير الملكية/الاسم.
المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة	الدواء والمستلزمات والتداول والرقابة؛ ترخيص الصيدلية الخاصة يتم ضمن التشريعات الصيدلانية والصحية النافذة.	التجهيز والشراء والتشغيل.
إدارة ترخيص السواقين والمركبات	ترخيص مركبات الإسعاف بعد الموافقات الفنية ذات العلاقة.	قبل الجاهزية والتجديد.
شركة المياه/الصرف وشركة الكهرباء والاتصالات	موافقات ربط وقدرات وخدمات واستمرارية.	جدوى الموقع، التصميم، التشغيل.

4. المراحل التنفيذية من الفكرة حتى التشغيل

المرحلة 0 — قرار الاستثمار والنطاق

- تحديد عام/متخصص، عدد الأسرة المرخصة، التخصصات، التعليم/التدريب إن وجد، العيادات الخارجية، قائمة الوحدات الإضافية، المشرحة، الصيدلية والمختبر والتصوير.
- تثبيت هيكل الملكية وأهلية مقدم الطلب: طبيب/طبيب أسنان مرخص، مؤسسة نفع عام/نقابة/جمعية، أو شركة مسجلة وفق النظام.
- إعداد مصفوفة سعة تشغيلية: الأسرة الفعلية والمرخصة، أسرة العناية، غرف العمليات، الولادة، الخداج، الغسيل، الأشعة، المواقف، الإسعاف.
- تعيين مدير مشروع ترخيص واحد وسجل قرارات مركزي؛ لا تُقبل تعليمات شفوية دون محضر أو كتاب.

المرحلة 1 — العناية الواجبة للموقع

- الحصول على سند تسجيل حديث ومخطط أراضٍ ومخطط موقع تنظيمي حديث وكشف قيود ورهون وحقوق مرور.
- كتاب استعمال/تنظيم يثبت جواز المستشفى والسعة/الارتفاعات/الارتدادات والمداخل والمواقف، وليس مجرد استعمال تجاري عام.
- دراسة وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني وفصل الحركة العامة والخدمة والنفايات والجثامين قدر الإمكان.

- فحص توفر شبكة صرف صحي وقدرة المياه والكهرباء والاتصالات. في غياب الصرف يجب خزان إسمنتي مصمت غير نافذ، مع موافقات التصريف والنقل.
- مسح بيئي أولي يشمل الضوضاء، النفايات، التخزين، الوقود، الأكسجين، أي محطة معالجة أو محرقة، وتأثير الأشعة.
- اختبار استيعاب المواقف النظامية المطلوبة دون الاعتماد على وعود استئجار غير موثقة أو أراضٍ لا تدخل في الترخيص.

المرحلة 2 — البرنامج الطبي والمخطط المفهومي

- إعداد برنامج غرف مع المساحات الصافية والإجمالية، العلاقات، أعداد الأسرة والأجهزة والمخازن والكوادر لكل قسم.
- رسم مسارات منفصلة: مريض/زائر، إسعاف، موظفون، مواد نظيفة، مواد ملوثة، غذاء، غسيل، نفايات، جثامين، صيانة.
- إعداد مصفوفة ضغط وتهوية وكهرباء وغازات طبية واحتياطيات لكل غرفة، لتُعتمد لا لتُفترض.
- تنسيق مبكر مع موردي الأجهزة الحرجة لتثبيت الأوزان، الحمولات، التدريع، التبريد، الطاقة، الغازات والصيانة.

المرحلة 3 — طلب وزارة الصحة والموافقة المبدئية

- طلب رسمي يحدد موقع المستشفى ونوعه وسعته وخدماته.
- إرفاق مخطط موقع تنظيمي حديث، سند الملكية/إثبات الحق، شهادة تسجيل الشركة وغاياتها وعقدها/نظامها عند الطلب، والمخططات الهندسية.
- استلام ملاحظات اللجنة وتعديل المخططات وإعادة تقديمها حتى الموافقة.
- تسجيل تاريخ الموافقة المبدئية وموعد انتهاء الخمس سنوات؛ أي تغيير تفرضه الأمانة/البلدية أو نقابة المهندسين يُبلغ للجنة.

المرحلة 4 — التصميم التفصيلي والاعتمادات

- تطوير معماري وإنشائي وكهربائي وميكانيكي وغازات طبية وحريق وتدريع وأمن ومعلومات ونفايات ومطبخ ومغسلة.
- تدقيق الكودات الوطنية وحسابات الإخلاء والحريق والأحمال والتكييف والمياه والطاقة وجودة الهواء.
- استكمال موافقات الدفاع المدني، البلدية/الأمانة، البيئة، الطاقة والمعادن للأشعة، ومقدمي الخدمات حسب النطاق.
- إصدار مصفوفة اعتماد لكل لوحة ومواصفة، ومنع طرح عطاء مبني على مخطط صحي فقط دون بقية الاعتمادات.

المرحلة 5 — رخصة البناء والتعاقد

- إصدار رخصة بناء سارية بالمخططات المختومة وتحديد المقاول والمشرف المرخصين.
- إدراج اشتراطات الترخيص والكودات واختبارات القبول ووثائق التسليم في العقود وجداول الكميات.
- اعتماد المواد المقاومة للحريق والتشطيبات الصحية والأبواب والمصاعد والأنظمة الطبية قبل التوريد.

المرحلة 6 — الإنشاء وضبط التغييرات

- تنفيذ نقاط توقف إلزامية قبل إغلاق الأسقف والجدران للتدريع والحريق والغازات والكهرباء الطارئة والتهوية.
- أي تعديل يغير غرفة أو ممر أو مخرجاً أو ارتفاعاً أو قسماً أو سعة أو استعمالاً يُراجع أثره الترخيصي ويعتمد قبل التنفيذ.
- الاحتفاظ بسجل صور واختبارات وشهادات منشأ ونتائج لحام/ضغط/عزل/تدريع ومعايرة.

المرحلة 7 — التشغيل التجريبي والاستلام

- اختبارات تكامل الحريق، فصل الكهرباء، المولد وATS وUPS، الغازات الطبية، المصاعد، التهوية والضغط، المياه والصرف، الأمن والاتصالات.
- إعداد مخططات كما نُفذ، أدلة التشغيل والصيانة، قوائم الأصول، الضمانات، التدريب، قطع الغيار وخطة الصيانة الوقائية.
- تنفيذ محاكاة طوارئ وإخلاء وانقطاع كهرباء/مياه/غاز وفشل نظام معلوماتي وحادث جماعي.

المرحلة 8 — إذن الأشغال وموافقات ما قبل التشغيل

- كشف الدفاع المدني وإقفال الملاحظات والحصول على التوصية اللازمة لإذن الأشغال/رخص المهن.
- إصدار إذن الأشغال من الجهة التنظيمية بعد مطابقة المنفذ للرخصة والمخططات.
- استكمال موافقات البيئة والصرف والمياه والكهرباء والمصاعد حسب جهة الاختصاص.

المرحلة 9 — ملف الجاهزية الصحي

- تراخيص الصيدلية والمختبر والأشعة والوحدات التخصصية وسيارات الإسعاف.
- قوائم الموظفين ومزاولات المهن والعقود والتغطية 7/24 ونسب الأردنيين.
- اللجان والسياسات والأسعار والسجلات الإلكترونية وخطط العدوى والنفايات والطوارئ والجودة.
- طلب كشف الجاهزية النهائي من وزارة الصحة مع المخططات النهائية المختومة ووثائق الاستلام.

المرحلة 10 — الترخيص النهائي وإذن المباشرة

- كشف لجنة المستشفيات الخاصة وتوثيق الملاحظات وتواريخ الإغلاق.
- دفع الرسوم بعد الموافقة واستلام وثيقة الترخيص موقعة ومختومة.
- استلام إذن مباشرة العمل من الوزير؛ التشغيل أو استقبال المرضى قبله مخالفة صريحة.

المرحلة 11 — الامتثال بعد الافتتاح

- التجديد كل خمس سنوات والتحضير له قبل ستة أشهر.
- عدم تغيير النوع/التخصص/الأسرة أو إضافة مبنى/طابق/وحدة أو نقل الموقع دون موافقة مسبقة.
- قوائم العاملين للوزارة كل ستة أشهر، أسعار معتمدة ومعلنة مسبقاً، فواتير تفصيلية، ملفات إلكترونية وحفظها للمدة القانونية.
- اختبارات دورية للحريق والمولدات والغازات والمصاعد والتدريع والمعايرة، وتقارير نفايات وسلامة وعدوى وتدريب.

5. ملف وزارة الصحة: الوثائق والإجراءات

5.1 وثائق التقديم الأولي

الوثيقة	متطلبات الضبط	ملاحظات
طلب إنشاء وترخيص	اسم الكيان، الموقع، نوع المستشفى، السعة، التخصص والخدمات والوحدات.	يوقعه المفوض قانوناً ويطابق غايات الشركة.
مخطط موقع تنظيمي حديث	صادر عن الأمانة/البلدية المختصة وساري.	يظهر الاستعمال والشوارع والقيود التنظيمية.
سند تسجيل الأرض	حديث مع القيود؛ وإثبات حق الإشغال/الانتفاع إن لم تكن الملكية مباشرة.	مدة العقد يجب أن تدعم كامل دورة المشروع والتشغيل.
شهادة تسجيل الشركة/المؤسسة	سارية وغاياتها تسمح بالمستشفى والخدمات.	أرفق عقد التأسيس والنظام الداخلي والتفويض عند طلب المديرية.
مخططات هندسية	معماري مبدئي على الأقل، يوضح كل طابق والاستعمالات والأبعاد والأسرة والحركة.	النسخة النهائية قبل الكشف تحمل موافقات الأمانة/البلدية والدفاع المدني.
برنامج طبي ووصف خدمات	جداول الأسرة والأقسام والأجهزة وساعات العمل.	ليس دائماً اسماً مستقلاً في نموذج الخدمة لكنه يمنع الالتباس وإعادة التصميم.
كتب الموافقات الخاصة	بيئة، إشعاع، وحدات تخصصية وغيرها حسب النطاق.	تُرفق في البوابة المناسبة ولا تنتظر الكشف النهائي.

5.2 تسلسل الإجراء وفق دليل خدمات 2026

11. تقديم الطلب والوثائق لدى وزارة الصحة/مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية.

12. دراسة الملف والمخططات؛ إما موافقة مبدئية مشروطة أو طلب تعديلات.
13. إعادة تقديم المخططات المعدلة وإقفال الملاحظات.
14. استلام الموافقة المبدئية؛ مدة صلاحيتها خمس سنوات وفق تعديل 2022.
15. بعد إتمام البناء والتجهيز، تقديم طلب جاهزية للحصول على الموافقة النهائية وإذن المباشرة.
16. تنسيق الكشف الموقعي للجنة المستشفيات الخاصة.
17. مناقشة نتيجة الكشف وتحديد النواقص أو الموافقة والرسوم.
18. دفع الرسوم النظامية وتراخيص الصيدلية/المختبر/الوحدات الإضافية حسب الحالة.
19. استلام الترخيص النهائي الموقّع والمختوم وإذن مباشرة العمل قبل استقبال المرضى.

زمن المعاملة

تجنب إدراج مدة ثابتة للمشروع على أساس مدة خدمة إدارية فقط. النظام يذكر دراسة اللجنة للطلب، لكن المدة الواقعية تتأثر بجودة المخططات، عدد جولات الملاحظات، الجهات المتوازية، ورخصة البناء والإنشاء. استخدم جدولاً قائماً على بوابات اعتماد لا على تاريخ افتتاح تسويقي.

5.3 الرسوم التي يجب تضمينها في الميزانية

البند	القيمة المنشورة	ملاحظة
ترخيص المستشفى لأول مرة	100 دينار أردني لكل سرير	يستوفى بعد موافقة اللجنة؛ تحقق من المطالبة الرسمية عند الدفع.
تجديد ترخيص المستشفى	75 ديناراً لكل سرير كل خمس سنوات	وفق تعديل 2022؛ خصم 25% في الحالات المحددة بالنظام.
صيدلية خاصة داخل المستشفى	2,000 دينار	بدل مستقل وفق دليل خدمات 2026.
مختبر داخل المستشفى	100 دينار	بدل مستقل وفق دليل خدمات 2026.
وحدة قسطرة قلب وأوعية	1,000 دينار	إضافة للمستشفى؛ لا يغني البدل عن استيفاء التعليمات والكشف.
وحدة تفتيت حصى	1,000 دينار	إضافة للمستشفى؛ تخضع للتعليمات.
وحدة تنظير الجهاز الهضمي	1,000 دينار	إضافة للمستشفى؛ تخضع لتعليمات رقم 4 لسنة 2019.
رسوم الدفاع المدني/التدقيق/البلدية/النقابة/البيئة/الإشعاع	متغيرة	تطلب عروض رسوم محدثة بناءً على المساحة والأنظمة والأجهزة ونطاق المشروع.

6. المتطلبات المعمارية والإنشائية الرقمية

الفرق بين الحد الصحي والحد الكودي

الرقم الوارد في نظام المستشفيات هو حد صحي عام، لكنه لا يعفي من كود الحريق أو التنظيم أو متطلبات ذوي الإعاقة. مثال: عرض الممر 2.40 م حد أدنى صحي؛ إذا نتج عن حساب الإخلاء أو دوران النقالات أو متطلبات الحريق عرض أكبر، يُطبق الأكبر.

6.1 جدول الأبعاد والقيم الملزمة صراحة

العنصر	الحد الأدنى/الشرط	طريقة القياس أو الضبط
غرفة الجناح (Suite)	20 م²	مساحة الغرفة الصافية؛ لا تُحسب مساحة المرفق الصحي ضمنها.
غرفة الدرجة الأولى — سرير واحد	12 م²	مساحة صافية للغرفة دون الحمام.
غرفة الدرجة الثانية — سريران	16 م²	مساحة صافية للغرفة دون الحمام.
غرفة الدرجة الثالثة	8 م² لكل سرير	صافي مساحة الغرفة؛ الحمام خارج الحساب.
مرافق غرف المرضى	مرفق صحي لكل غرفة؛ وللدرجة الثالثة حمام واحد على الأقل لكل 3 أسرّة	لا تُحتسب مساحة الحمام ضمن مساحة غرفة المريض.
عرض الممرات	2.40 م على الأقل	عرض صافٍ خالٍ بعد التشطيبات والدرابزين والحواجز والمعدات؛ مع تطبيق الكود الأشد.
سقف غرف العمليات	3.50 م إنشائياً؛ 3.00 م صافي تحت السقف المستعار	من منسوب البلاط النهائي إلى أسفل السقف/الجسر؛ لا تُنزّل الخدمات الصافي المطلوب.
سقف غرف المرضى	2.70 م على الأقل	صافي من البلاط النهائي إلى أسفل السقف/العائق الثابت.
سقف المطابخ	2.50 م على الأقل	صافي بعد التهوية ومجاري الشفط.
سقف الحمامات والمرافق الصحية	2.40 م على الأقل	القيمة المحدثة في تعديل 2022.
خزن المياه	250 م³ على الأقل	حد أدنى للمستشفى؛ يلزم أيضاً حساب الطلب الفعلي ومدة الاستمرارية وجودة الخزانات.
خزن الوقود	يكفي استهلاك أسبوعين على الأقل	يوثق بحساب حمل المولدات والمراجل واختبارات التشغيل، مع اشتراطات البيئة والحريق.
المواقف المجانية	موقف لكل سرير + موقف لكل 100 م² من مساحة مبنى المستشفى	تتحقق أيضاً متطلبات التنظيم المحلي وذوي الإعاقة ومسارات الإسعاف والحريق.
العناية الحثيثة	عام: 4 أسرّة؛ متخصص: سريران؛ مع سرير عزل واحد	يُثبت بالمخطط والتجهيز والكوادر؛ لا يدمج سرير العزل بمسار ملوث غير معتمد.
غرف العمليات	غرفتان على الأقل	إضافة إلى التحضير والإفاقة وغرفتي غيار واستراحة؛ المساحة الأرضية تحدد بالتعليمات/اعتماد المخططات.
المشرحة	حجرة تبريد واحدة على الأقل لكل 50 سريراً	التقريب للأعلى واحتساب السعة الفعلية.

العنصر	الحد الأدنى/الشرط	طريقة القياس أو الضبط
الإسعاف	سيارتان حتى 100 سرير؛ واحدة متاحة 7/24؛ + سيارة لكل 100 سرير إضافية	ترخيص وتجهيز ومواقف ومسار واستمرارية.

6.2 الاشتراطات العامة الملزمة للمبنى

الاشتراط	الحكم التنفيذي
اتصال المبنى	لا يتصل بمبنى آخر إلا إذا كان المبنى الآخر لخدمات طبية/صحية أو خدمات مساندة للمستشفى.
الساحات والحركة	ساحات خارجية مسوّرة، ومدخل منفصل عن المخرج؛ يثبت الحل بالمخطط وبالتنفيذ.
الإنارة والتهوية	إنارة وتهوية طبيعية أو صناعية في المرافق، مع تطبيق المتطلبات الأشد للأقسام الحرجة.
الراحة الحرارية	تدفئة وتبريد كافيان لجميع الوظائف؛ يثبتان بالحساب والاختبار.
المياه	تمديدات مياه باردة وساخنة، وخزن لا يقل عن 250 م³.
الصرف	تمديدات لطرح الفضلات السائلة؛ وخزان إسمنتي مصمت غير نافذ إذا لم توجد شبكة صرف صحي.
النفايات	وسائل صحية لجمع الفضلات السائلة والجافة والنفايات الطبية والتخلص منها وفق التشريعات والمواصفات المعتمدة.
الكهرباء الاحتياطية	مولد ذاتي التشغيل للمتطلبات الضرورية والطارئة؛ ومصدران احتياطيان على الأقل للأنظمة المرتبطة مباشرة بحياة المريض.
الوقود	خزانات تكفي استهلاك أسبوعين على الأقل، مع متطلبات البيئة والحريق.
المصاعد	مصاعد كهربائية تتناسب مع عدد الأسرة وحجمها؛ يثبت العدد والحجم بدراسة حركة واعتماد.
الغازات الطبية	وحدة غازات طبية وفق تعليمات الوزير واعتماد الجهة المختصة.
الإتاحة	تطبيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المرافق، إضافة إلى الكود الوطني والتنظيم المحلي.

6.3 مساحة غرفة العمليات: ما هو ملزم وما ليس ملزماً

لا يتضمن النص المنشور لنظام المستشفيات الخاصة، حتى تاريخ القطع، رقماً موحداً لمساحة غرفة العمليات بالمتر المربع. النص الملزم يحدد العدد والفراغات التابعة والارتفاعات، ويفوض الوزير بإصدار الشروط والمواصفات والمعايير التصميمية. لذلك لا يجوز إدراج رقم مأخوذ من كود أجنبي أو ممارسة سوقية على أنه «الحد الأردني للترخيص» دون كتاب/تعليمات حالية معتمدة من وزارة الصحة.

يُثبت الآن	يُعتمد قبل تجميد التصميم	لا يُفترض

يُثبت الآن	يُعتمد قبل تجميد التصميم	لا يُفترض
غرفتا عمليات على الأقل؛ تحضير؛ إفاقة؛ غرفتا غيار؛ استراحة؛ الارتفاعات النظامية.	نوع كل غرفة، المساحة الصافية، مناطق التحكم، مسارات النظيف/الملوث، التهوية والضغط، عدد المخارج، البندنتات، مناطق نقل المرضى، غرفة الأجهزة والتخزين.	أن غرفة العمليات العامة تصلح آلياً للعظام/القلب/الروبوت/الهجين، أو أن رقم مساحة غير أردني يكفي للترخيص.

نقطة توقف إلزامية

يصدر الاستشاري جدول غرف العمليات وأنواعها والأجهزة الثابتة والمتحركة وحرم الصيانة، ويطلب اعتماداً خطياً من مديرية الترخيص قبل إصدار المخطط التنفيذي. غرفة هجينة أو روبوتية أو قلب مفتوح تُعامل كمشروع جهاز/بنية لا كغرفة عمليات عامة مكبرة فقط.

6.4 عناصر لا يجوز إعطاؤها رقماً عاماً دون حساب كودي

العنصر	لماذا لا يوجد رقم واحد	وثيقة الإثبات المطلوبة
عرض المخارج والأبواب والسلالم	يعتمد على حمل الإشغال، استراتيجية الإخلاء المرحلي، التقسيمات ونوع المبنى.	حساب إخلاء مختوم ومخطط حريق معتمد من الدفاع المدني.
عدد المصاعد وأبعاد مصعد السرير	يعتمد على الأسرة والطوابق والنقل والخدمة والزمن التشغيلي.	دراسة حركة ومواصفة سرير/نقالة وموافقة الجهة التنظيمية.
معدلات تغيير الهواء والضغط والترشيح	تختلف حسب وظيفة الغرفة ونوع الإجراء والمخاطر.	مصفوفة غرف HVAC معتمدة ونتائج اختبار TAB/HEPA/الضغط.
حجم خزان الحريق وقدرة المضخات	نتيجة تصنيف الخطر ومساحة المبنى ونظام الرش/الخراطيم والزمن.	حساب هيدروليكي واعتماد الدفاع المدني.
قدرة المولد وUPS	تعتمد على قائمة الأحمال الطبية الحرجة وزمن الاستمرارية وتتابع البدء.	دراسة أحمال، انتقائية، قصر، سيناريو فشل واختبار حمل.
سماكات التدريع	تعتمد على الجهاز والطاقة والاستخدام والإشغال المجاور.	تقرير فيزيائي طبي/وقاية إشعاعية معتمد من هيئة الطاقة والمعادن.
مساحة أقسام الطوارئ والمختبر والصيدلية والتعقيم	مرتبطة بالحجم التشغيلي والتجهيز وتدفق العمل وتعليمات الوزير.	برنامج طبي + قائمة أجهزة + مخططات معتمدة من الصحة والجهات الخاصة.

7. متطلبات الأقسام والخدمات بالمستشفى

الجداول التالية تفصل بين الحد النظامي الصريح وبين عناصر التصميم والتشغيل التي يجب إثباتها للحصول على موافقة المخططات والكشف. عبارة «حسب التعليمات» تعني ضرورة الحصول على النسخة النافذة من المديرية وعدم الاكتفاء بهذا التقرير.

7.1 قسم الإسعاف والطوارئ

البعد	المتطلب التنفيذي
الحد النظامي	قسم إلزامي. في المستشفى المتخصص تكون الطوارئ ضمن تخصصه وإمكاناته، مع التغطية اللازمة.

البعد	المتطلب التنفيذي
التخطيط	مدخل إسعاف واضح ومغطى؛ فصل مناسب عن الجمهور؛ فرز؛ إنعاش؛ فحص وعلاج؛ عزل؛ ملاحظة؛ أدوية ومستهلكات؛ مرافق موظفين؛ اتصال مباشر بالتصوير والمختبر والعمليات والعناية؛ مسار حادث جماعي.
الهندسة	طاقة وغازات واتصالات حرجة، نداء تمريض، إنذار، غسيل يد، أسطح قابلة للتنظيف، تهوية/ضغط العزل وفق مصفوفة معتمدة.
التشغيل	تغطية 7/24، بروتوكولات فرز وإنعاش ونقل، عربات طوارئ مفحوصة، اتفاقات نقل عند تجاوز القدرة، سجل زمن الاستجابة.
دليل الإقفال	قائمة أجهزة، جدول مناوبات، تراخيص الكادر، نتائج اختبار الغازات والطاقة والنداء، محاكاة حادث جماعي.

7.2 قسم الأشعة والتصوير الطبي

البعد	المتطلب التنفيذي
الحد النظامي	قسم أشعة إلزامي؛ كل ممارسة مؤينة تحتاج ترخيصاً مؤسسياً، والعاملون يحتاجون الرخص/التصاريح المناسبة من هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.
التخطيط	تحديد modalities منذ البداية: أشعة عامة، متنقلة، C-arm، CT، ماموغرام، قسطرة، طب نووي أو علاج إشعاعي. فصل انتظار المرضى المنومين/الخارجيين عند الحاجة، تبديل، حقن، إفاقة، تحكم، معدات وتقنية.
التدريع	تقرير مبني على نموذج الجهاز والطاقة وعبء العمل واتجاه الحزمة وإشغال الفراغات المجاورة؛ لا تُحدد السماكات بالخبرة العامة.
الموافقات	موافقة الهيئة قبل الاستيراد/الحيازة/التشغيل، مخططات التدريع، رخص العاملين، قياسات مسح بعد التركيب، ضبط جودة ومعايرة وخطة نفايات مشعة للطب النووي.
دليل الإقفال	رخصة مؤسسية، رخص العاملين، تقرير التدريع والمسح، قبول المصنع، QC، سجل الجرعات الشخصية، خطة الطوارئ الإشعاعية.

7.3 المختبر وبنك الدم/ثلاجة الدم

البعد	المتطلب التنفيذي
الحد النظامي	قسم مختبر إلزامي مع ثلاجة مخصصة للدم ومشتقاته وفق التشريعات ذات العلاقة؛ بدل المختبر داخل المستشفى 100 دينار وفق دليل 2026.
التخطيط	استقبال عينات، سحب، معالجة، تحاليل، أحياء دقيقة عند النطاق، مخازن باردة ومواد خطرة، غسل، نفايات، استراحة، فصل حركة العينات والجمهور.
الدم	تحديد هل الخدمة تخزين وصرف فقط أم بنك دم/نقل دم كامل؛ لكل نطاق متطلبات وترخيص ومراقبة حرارة وتتبع وعدم انقطاع كهرباء.

البعد	المتطلب التنفيذي
الجودة	ضبط جودة داخلي وخارجي، معايرة، تحقق طرق، درجات حرارة، سلسلة تبريد، سلامة حيوية، إدارة كواشف، نتائج حرجة وتتبّع العينة.
دليل الإقفال	ترخيص المختبر ومسؤول فني مرخص، قوائم الأجهزة، شهادات المعايرة، درجات الحرارة، SOPs، اختبارات الطوارئ والاحتياط.

7.4 مجمع العمليات والتخدير والإفاقة

البعد	المتطلب التنفيذي
الحد النظامي	غرفتا عمليات على الأقل، تحضير، إفاقة، غرفتا غيار للعاملين، استراحة. ارتفاع 3.50 م إنشائياً و3.00 م تحت السقف المستعار.
التدفق	منطقة غير مقيدة/شبه مقيدة/مقيدة؛ فصل مسار الأدوات النظيفة والملوثة؛ استقبال المريض وتحقق الهوية؛ تخزين معقم؛ نفايات؛ خروج إلى الإفاقة والعناية.
الهندسة	تهوية وضغط وترشيح معتمد، طاقة طبيعية وطارئة وUPS حسب الجهاز، غازات طبية وشفط، تأريض وتكافؤ جهد، إضاءة جراحية، حماية حريق، اتصالات ونداء.
التخدير	منطقة تحضير/تخزين آمن للأدوية والغازات، اختبار أجهزة التخدير والـ scavenging، عربة صعب مجرى الهواء، بروتوكولات إنعاش ونقل.
دليل الإقفال	اعتماد layout، اختبارات HVAC والضغط والجسيمات إن طلبت، اختبار الغازات، التأريض، طاقة الطوارئ، جدول الأدوات، صلاحية التعقيم، محاكاة الحريق/الفشل.

7.5 العناية الحثيثة والعزل

البعد	المتطلب التنفيذي
الحد النظامي	العام: 4 أسرّة على الأقل؛ المتخصص: سريران على الأقل؛ مع سرير عزل واحد.
التخطيط	رؤية تمريضية، مساحة تحكم وعلاج، دواء، نظيف/ملوث، أجهزة، غازات لكل سرير، مخزن، مرافق أسرة، مسار نقل مباشر للتصوير والعمليات.
العزل	غرفة عزل فعلية بباب/منطقة دخول وغسيل يد وتهوية/ضغط مناسب لنوع الاستخدام، مع مراقبة الضغط وخطة فشل؛ يثبت بالاختبار.
الاستمرارية	نظاما احتياط على الأقل للأنظمة المرتبطة مباشرة بحياة المريض، مع تفسير موثق لمصادر الطاقة والغازات والاتصالات.
دليل الإقفال	قوائم أجهزة، تراخيص الكادر، جداول 7/24، نتائج الضغط والإنذار، اختبارات الطاقة والغاز، بروتوكولات الإنعاش والنقل.

7.6 التنويم وغرف المرضى

البعد	المتطلب التنفيذي
الحد النظامي	المساحات: جناح 20 م²، مفرد 12 م²، مزدوج 16 م²، درجة ثالثة 8 م²/سرير؛ الحمام خارج المساحة. سقف 2.70 م. ممر 2.40 م.
التخطيط	تثبيت التصنيف وعدد الأسرة بكل غرفة، عدم اعتبار أسرة الملاحظة/الإفاقة أسرة تنويم دون اعتماد، محطات تمريض، دواء، نظيف/ملوث، بياضات، معدات، نفايات، عزل.
الإتاحة	غرف ومرافق ومسارات ومصاعد وأبواب وتجهيزات ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة وفق الكود الوطني والمتطلبات المحلية.
السلامة	نداء تمريض، غازات حسب البرنامج، مخارج، إنذار، أبواب وتقسيمات حريق، حماية سقوط، مياه ساخنة آمنة، خصوصية.
دليل الإقفال	جدول أسرة مرخصة مطابق للمخطط والواقع، قياسات صافية، قائمة غرف، اختبار النداء، المياه، الأبواب والحريق.

7.7 الصيدلية الخاصة بالمستشفى

البعد	المتطلب التنفيذي
الحد النظامي	صيدلية خاصة إلزامية؛ بدل الترخيص 2,000 دينار وفق دليل 2026.
الموقع	تكون داخل أحد طوابق إقامة المرضى؛ لا تكون بالطابق الأرضي أو طابق/مبنى العيادات الخارجية أو الساحات؛ لا باب خارجي ولا اتصال مباشر بالطريق العام.
الكادر	ثلاثة صيادلة مسؤولين على الأقل، وصيدلي سريري مزاول واحد على الأقل لكل 50 سريراً أو أقل، وفق دليل الخدمة المنشور.
التخطيط والتشغيل	استلام، حجر، تخزين بدرجات مضبوطة، ثلاجات مراقبة واحتياط، مخدرات/مؤثرات مؤمنة، تحضير وصرف، مرتجعات ومنتهيات، توصيل للأقسام، نظافة ونفايات.
دليل الإقفال	ترخيص المؤسسة والصيادلة، مخطط معتمد، درجات حرارة، مخزون مراقب، SOPs، قوائم أدوية، تأمين، اختبار الكهرباء الاحتياطية.

7.8 وحدة التعقيم المركزي CSSD

البعد	المتطلب التنفيذي
الحد النظامي	وحدة إلزامية وفق الشروط والمواصفات التي يصدرها الوزير.
التدفق	أحادي الاتجاه: استلام ملوث ← تنظيف/إزالة تلوث ← فحص وتجميع وتغليف ← تعقيم ← تخزين معقم وتوزيع؛ منع التقاطعات.
الهندسة	مياه وجودة بخار/هواء، فصل وضغط وتهوية، أحواض وتجفيف، صرف، حماية حرارية، كهرباء احتياط للأحمال الحرجة، مساحات صيانة.

البعد	المتطلب التنفيذي
الجودة	اختبارات ميكانيكية وكيميائية وبيولوجية، تتبع الحمولة للأداة/المريض، تأهيل IQ/OQ/PQ، معايرة وصيانة واستدعاء الأحمال.
دليل الإقفال	مخطط مناطق وضغوط، نتائج التأهيل والاختبارات، SOPs، كفاءة الكادر، سجل التتبع، عقد صيانة.

7.9 التغذية والمطبخ

البعد	المتطلب التنفيذي
الحد النظامي	قسم تغذية/مطبخ لإعداد وتجهيز وجبات المرضى والعاملين؛ ارتفاع السقف 2.50 م على الأقل.
التخطيط	استلام منفصل، مخازن جاف/مبرد/مجمد، تحضير خام، طبخ، توزيع، عودة وغسيل، نفايات؛ فصل الخام عن المطبوخ والحساسيات والحميات.
السلامة	شفاطات ودهون وإطفاء مناسب، غاز/وقود آمن، مياه ساخنة، مكافحة آفات، أسطح صحية، درجات حرارة وسلسلة باردة.
التشغيل	سياسات استلام وحفظ وإعداد وتوزيع تعتمدها اللجنة الفنية؛ فحوص العاملين بحسب المتطلبات الصحية.
دليل الإقفال	مخطط تدفق، موافقات الغذاء/الصحة حسب الاختصاص، نظام HACCP عملي، سجل درجات الحرارة، مكافحة آفات وتدريب.

7.10 المخازن وسلسلة التزويد

البعد	المتطلب التنفيذي
الحد النظامي	مستودعات لوازم إلزامية.
التقسيم	عام، طبي، تعقيم، صيانة، قطع غيار، مواد خطرة/قابلة للاشتعال، غازات؛ فصل الحجر والمنتهيات والمرتجعات.
الضبط	حرارة ورطوبة عند الحاجة، رفوف وخلوص، أمن، FIFO/FEFO، مكافحة آفات، جرد، استمرارية سلسلة التبريد.
دليل الإقفال	قائمة مخازن، تصنيف خطر، SDS، درجات حرارة، نظام جرد، خطة طوارئ وإطفاء.

7.11 المغسلة والتدبير المنزلي

البعد	المتطلب التنفيذي
الحد النظامي	التدبير المنزلي خدمة إلزامية؛ قد تكون المغسلة داخلية أو متعاقداً عليها وفق قبول الجهة، لكن مسارات البياضات تبقى مسؤولية المستشفى.

البعد	المتطلب التنفيذي
التخطيط	فصل واضح للبياضات النظيفة والملوثة، عربات مغلقة، غرف خدمة نظيف/ملوث بكل منطقة، مخازن كيماويات مؤمنة ومهوّاة.
التشغيل	جداول تنظيف بحسب المخاطر، أدوات ملوّنة/مخصصة، معالجة انسكاب، PPE، رقابة عقد الطرف الثالث، منع خلط النفايات بالبياضات.
دليل الإقفال	سياسات، خرائط مسارات، عقود وموافقات، سجلات تدريب ومواد، تدقيق نتائج النظافة.

7.12 المشرحة وحفظ الموتى

البعد	المتطلب التنفيذي
الحد النظامي	حجرة تبريد واحدة على الأقل لكل 50 سريراً.
التخطيط	مسار خاص غير مكشوف للجمهور وبعيد عن الغذاء والنظيف، استلام وتسليم وهوية وأمن، غسل وتنظيف، تهوية وصرف مناسب، مساحة للطب الشرعي إن كان ضمن النطاق ومصرحاً.
الاستمرارية	تبريد على مصدر طوارئ وإنذار حرارة ومراقبة ودليل تعامل مع الأعطال والسعة الزائدة.
دليل الإقفال	احتساب الحجرات، اختبار حرارة وإنذار، سياسة الهوية والتسليم، خطة حالات الوفاة الجماعية.

7.13 سيارات الإسعاف

البعد	المتطلب التنفيذي
الحد النظامي	سيارتان للمستشفى حتى 100 سرير، إحداهما متاحة 24 ساعة؛ سيارة إضافية لكل 100 سرير إضافية.
الموافقات	تجهيز وفق مواصفات وزارة الصحة، كشف وتجديد، وكتاب للترخيص المروري عند الإجراء.
التشغيل	طاقم مؤهل، قائمة معدات وأدوية، فحص يومي، تنظيف وعدوى، اتصال وتتبّع، صيانة، تغطية عند خروج مركبة للصيانة.
دليل الإقفال	رخص المركبات والكادر، سجلات الجاهزية، المعدات، الصيانة، التأمين، موقع الوقوف ومسار الدخول.

7.14 السجلات والمعلومات والاتصالات

البعد	المتطلب التنفيذي
الحد النظامي	سجل مرضى، محاسبة، استعلامات، مكتبة ومراجع طبية، ونظام إدارة معلومات. ملف إلكتروني لكل مريض داخلي وفق تعديل 2022.
السجل	هوية، أوامر، نتائج، صور، دواء، تخدير، عمليات، موافقات، خروج وفواتير؛ حماية الصلاحيات والأثر التدقيقي وعدم العبث.

البعد	المتطلب التنفيذي
الاستمرارية	مركز بيانات/سحابة معتمدة، نسخ احتياطي واختبار استعادة، طاقة وUPS، شبكة طبية منفصلة، خطط توقف يدوي واسترجاع.
المهلة	خطة تحول كاملة قبل 2027/11/16 ما لم يصدر نص لاحق؛ الاحتفاظ الإلكتروني لا يقل عن عشر سنوات من آخر إدخال، عدا القضايا.
دليل الإقفال	اختبار مستخدمين، الأمن السيبراني، النسخ والاستعادة، downtime drill، عينات ملفات كاملة وسياسة حفظ وإتلاف.

7.15 الصيانة والهندسة الطبية

البعد	المتطلب التنفيذي
الحد النظامي	الصيانة إلزامية؛ مستشفى يزيد على 100 سرير يعين مهندس أجهزة طبية.
النظام	سجل أصول موحد، خطورة، صيانة وقائية، معايرة، أعطال وقطع، استدعاءات، قبول قبل الاستخدام، إخراج آمن من الخدمة.
المرافق	ورشة/مخزن وبيئة عمل آمنة، وصول للصيانة دون اختراق المناطق النظيفة، إدارة مقاولين وتصاريح عمل.
دليل الإقفال	قائمة 100% من الأصول الحرجة، شهادات قبول ومعايرة، خطة سنوية، KPI، عقود ودليل مهندس الأجهزة الطبية عند اللزوم.

7.16 النسائية والتوليد وحديثو الولادة والخداج

العنصر	الحد/المتطلب	إجراء التصميم
غرف الولادة	غرفتا ولادة على الأقل.	تثبيت نمط الولادة والخدمات والإنعاش والخصوصية والغازات والطاقة.
غرف المخاض	غرفتا مخاض على الأقل.	فصل/ربط وظيفي مع الولادة والعمليات والطوارئ.
الخداج NICU	خمس حاضنات وجهازا تنفس صناعي للمواليد على الأقل، مع مراعاة التعديلات والتعليمات النافذة.	إعداد قائمة أجهزة وكادر وغازات وعزل وعدوى وطاقة احتياط.
حديثو الولادة	غرف منفصلة عن الخداج؛ وتتسع لعدد أسرة لا يقل عن عدد أسرة الولادة وفق الأصل، مع التحقق من النص المعدل المطبق على سعة المشروع.	طلب تأكيد خطي من المديرية إذا كان المشروع كبيراً أو يفسر حد المادة 10 بعد تعديل 2022.
الروابط الحرجة	عمليات قيصرية، بنك دم، مختبر، عناية أمومة، إنعاش مولود، أمن وهوية.	محاكاة نزف ولادي وإنعاش مولود وفقد طفل/اختلاط هوية.

تحفظ قانوني محدد

تعديل 2022 استبدل رقماً في المادة 10 وفصل غرف حديثي الولادة عن قسم الخداج. عند تصميم مستشفى ولادة أو مشروع ذي سعة كبيرة، اطلب نسخة موحدة وموقعة من المادة 10 أو تفسيراً خطياً من المديرية قبل تثبيت أعداد الحاضنات/الأسرة؛ لا تعتمد نصاً غير موحد من الإنترنت.

8. الوحدات التخصصية والتراخيص المنفصلة

إدراج وحدة على المخطط أو شراء جهازها لا يعني السماح بتشغيلها. لكل وحدة ذات طبيعة خاصة ملف فني وكادر وتجهيزات وكشف وموافقة، وقد تجتمع عليها أكثر من جهة.

الوحدة/الخدمة	المرجع أو الجهة	بوابة عدم التجاوز
قسطرة القلب والأوعية	وزارة الصحة — تعليمات رقم 1 لسنة 2018؛ وهيئة الطاقة والمعادن للأشعة	اعتماد المخطط والتدريع والكادر والأجهزة قبل التوريد؛ بدل إضافة 1,000 دينار.
تفتيت الحصى	وزارة الصحة — تعليمات رقم 3 لسنة 2019؛ هيئة الطاقة والمعادن إذا كان الجهاز مؤيناً	موافقة قبل التركيب؛ بدل إضافة 1,000 دينار.
تنظير الجهاز الهضمي	وزارة الصحة — تعليمات رقم 4 لسنة 2019	تخطيط إفاقة وتعقيم/إعادة معالجة المناظير وتهوية وتخزين؛ بدل 1,000 دينار.
غسيل الكلى	تعليمات إنشاء وحدات غسيل الكلى لدى المستشفيات الخاصة لسنة 2024	موافقة مخطط ومياه معالجة وكادر وأجهزة؛ لا تشغيل قبل استيفاء التعليمات.
الإخصاب/أطفال الأنابيب	تعليمات 2024 المنشورة بالعدد 5954	وحدة مستقلة الضبط، كادر مرخص، مختبر أجنة وسجلات وأمن وخصوصية؛ موافقة قبل الإنشاء التفصيلي.
الطب النووي	هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن + وزارة الصحة	غرف حقن/انتظار/عزل إن لزم، تخزين وتحلل نفايات، صرف ورقابة جرعات؛ رخصة مؤسسية وشخصية.
العلاج الإشعاعي	هيئة الطاقة والمعادن + وزارة الصحة	تصميم bunker وتدريع متحقق، commissioning، interlocks وQA فيزيائي قبل علاج أول مريض.
الأشعة التداخلية/CT/C-arm	هيئة الطاقة والمعادن	اعتماد التدريع والترخيص والمسح بعد التركيب ورخص العاملين.
بنك الدم/خدمات نقل الدم	وزارة الصحة والتشريعات الخاصة بخدمات نقل الدم	تحديد النطاق والترخيص وسلسلة التتبع والتبريد والطوارئ.
مركز زراعة أعضاء/أنسجة/خلايا جذعية	وزارة الصحة والتشريعات النوعية	لا يدرج في غايات التشغيل قبل موافقات البرنامج واللجان والاعتماد الأخلاقي/الفني.
دراسات دوائية/بحوث على الإنسان	موافقة الوزير والجهات الأخلاقية والتنظيمية ذات العلاقة	ممنوعة دون الموافقات المسبقة حتى لو كان المستشفى مرخصاً.

الوحدة/الخدمة	المرجع أو الجهة	بوابة عدم التجاوز
غرفة ضغط/أكسجين عالي الضغط	وزارة الصحة + الدفاع المدني + جهات الغاز/الأجهزة	تحليل حريق وأكسجين وضغط، مخطط ومواصفة واعتماد قبل الشراء.

8.1 ملف نموذجي لأي وحدة تخصصية

- طلب رسمي ونطاق خدمة وعدد الأسرة/المحطات/الغرف والحالات المستهدفة.
- مخطط معماري بمسارات المرضى والموظفين والنظيف/الملوث والطوارئ، وجدول غرف ومساحات.
- قائمة أجهزة مصنعية نهائية مع متطلبات الطاقة والغازات والمياه والتبريد والتدريع والأوزان والصيانة.
- قائمة كادر بأسماء ومزاولات وخبرات وتغطية، ووصف وظيفي ومسؤول وحدة.
- سياسات القبول والخروج والطوارئ والعدوى والأدوية والنفايات والجودة والصيانة.
- تقارير قبول/معايرة/commissioning، عقود صيانة، تدريب المستخدمين، وخطة بديلة عند توقف الجهاز.
- كتاب موافقة/ترخيص صريح للوحدة قبل إدراجها في الإعلان أو استقبال الحالات.

9. المتطلبات الهندسية والبنية التحتية

9.1 الكهرباء والطاقة الاحتياطية

- مولد ذاتي التشغيل يكفي المتطلبات الضرورية والطارئة [م].
- الأنظمة المرتبطة مباشرة بحياة المريض لها مصدران احتياطيان على الأقل [م]؛ يوثق تعريف المصدرين واستقلاليتهما.
- تقسيم الأحمال إلى عادي، طارئ، حياة/حرج، وUPS؛ لوحات ومخارج مميزة، ATS، تسلسل بدء، انتقائية وحماية من القصر والتسرب.
- احتساب الأحمال الفعلية للأجهزة الطبية والتكييف والغازات والمصاعد والـIT، مع هامش التوسع المتفق عليه.
- اختبار بنك أحمال للمولد، انقطاع كامل، انتقال/عودة، استقلال الوقود أسبوعين، إنذار مستوى وتسرب، وخطة تزويد بديلة.
- تأريض وحماية صواعق وتكافؤ جهد للمناطق الطبية وفق الكودات الوطنية، مع قياسات موثقة.

9.2 الغازات الطبية والشفط

- وحدة غازات طبية وفق التعليمات [م] تشمل المصدر والتوزيع والإنذارات والتخزين والاحتياط.
- تحديد الأكسجين والهواء الطبي والشفط وN2O/CO2/غازات أخرى حسب الغرفة والخدمة، وليس نسخ مخطط عام.
- فصل مناطق التخزين، التهوية، الحماية من الحريق والمركبات، تثبيت الأسطوانات، إدارة المورد والتعبئة والطوارئ.
- اختبار ضغط وتسريب ونقاوة وتداخل وتعريف مخارج وتحقق zone valves والإنذارات قبل الاستخدام؛ شهادة طرف مؤهل.
- خطة انقطاع تشمل manifold احتياطي، أسطوانات متنقلة محسوبة، تحديد أولوية المرضى وتدريب الكادر.

9.3 التكييف والتهوية وجودة الهواء

- مصفوفة غرف معتمدة تبين درجة الحرارة والرطوبة والهواء الخارجي وتغييرات الهواء والترشيح واتجاه الضغط لكل وظيفة [ا].
- فصل أنظمة/مناطق عالية الخطورة عند الحاجة: العمليات، العزل، المختبر، المشرحة، النفايات، المطبخ، CSSD، الصيدلية والتحضير.
- فتحات سحب وطرد لا تعيد التلوث؛ وصول صيانة لا يعرّض المناطق النظيفة؛ مراقبة وضبط ضغط وإنذارات للمناطق الحرجة.
- اختبارات HEPA integrity، TAB إن انطبق، اتجاه الهواء، فروق الضغط، درجات الحرارة والرطوبة، وربطها بقبول القسم.

9.4 المياه والصرف

- خزن لا يقل عن 250 م³ [م]، مع فصل/حماية الخزانات وتنظيفها ومراقبة الجودة وحساب الطلب الفعلي.
- مياه ساخنة وباردة لجميع الاحتياجات [م]، مع ضبط مخاطر الحروق والليجيونيلا والركود والتدفق العكسي.
- إذا لا توجد شبكة صرف: خزان إسمنتي مصمت غير نافذ [م] وموافقات جمع ونقل وتصريف؛ لا يكفي تنفيذ حفرة امتصاصية.
- معالجة خاصة لمياه غسيل الكلى والمختبرات/العلاج الكيماوي/النفايات بحسب التعليمات؛ يمنع التصريف غير المعالج المحظور.
- خطة انقطاع مياه واختبار استمرارية، نقاط أخذ عينات، سجلات تعقيم وجودة.

9.5 المصاعد والنقل الرأسي

- مصاعد كهربائية تتناسب مع عدد الأسرة وحجمها [م].
- تحديد مصعد سرير/نقالة، خدمة/نفايات/بياضات، زوار وموظفين حسب حركة المشروع، مع أبعاد أبواب وكبائن وحمولات فعلية.
- استدعاء الحريق، طاقة طوارئ للمصاعد المحددة، اتصال إنقاذ، تهوية، حماية بئر، وصول صيانة وفحص الجهة المختصة.
- دراسة زمن انتقال وتكدس، وليس الاكتفاء بعدد مصاعد التنظيم العام.

9.6 الاتصالات والأنظمة منخفضة التيار

- نداء تمريض، code blue، هاتف وبيانات، شبكة أجهزة، ساعة موحدة، تلفزيون، وصول وأمن، CCTV حيث يسمح، إنذار حريق وتكامل BMS.
- ازدواج مسارات/مصادر الأنظمة الحرجة، UPS، غرف اتصالات محمية، تقسيم سيبراني، تسجيل ومراقبة.
- اختبار end-to-end من نقطة المريض إلى الاستجابة، وسيناريو توقف الشبكة والنظام الصحي الإلكتروني.

9.7 الوقود والمواد الخطرة

- خزن وقود لا يقل عن استهلاك أسبوعين [م]، مع حوض احتواء وتسرب وتهوية وإطفاء وتأريض وموافقات البيئة والدفاع المدني.
- سجل مواد خطرة وSDS، فصل المواد غير المتوافقة، خزائن مقاومة، حدود كميات، تهوية وانسكاب وتدريب.
- إدارة أسطوانات الغاز والمواد الكيماوية والمبردات والبطاريات والنفايات الخطرة ضمن الكودات والأنظمة الخاصة.

9.8 قائمة الكودات الوطنية التي يثبت فريق التصميم تطبيقها

المجال	الكودات/الموضوعات الواجب التحقق منها
إنشائي	استكشاف الموقع، الأحمال والقوى، الخرسانة، الفولاذ، الزلازل، الأساسات والجدران الاستنادية، العزل المائي والحراري.
حريق	الوقاية من الحريق، إنذار الحريق، أنظمة مكافحة الحريق، مخارج وإخلاء وتقسيمات ودخان حسب المبنى.
كهرباء	التمديدات، التأريض، الحماية من الصواعق، الإنارة الداخلية والطوارئ، مصادر الاحتياط والاستمرارية.
ميكانيك	التهوية الطبيعية، التهوية الميكانيكية والتكييف، التدفئة، المياه والصرف، الغازات، المصاعد.
إتاحة	متطلبات البناء للأشخاص ذوي الإعاقة، المواقف والمنحدرات والمسارات والمرافق والمصاعد والإشارات.
مساند	الصوتيات، كفاءة الطاقة، الاتصالات والبيانات، المراقبة، تخزين المواد الخطرة، الملاجئ حيث تنطبق.

النسخ الرسمية من الكودات

كثير من الكودات لا تتاح كاملة مجاناً. على الاستشاري والمقاول حيازة النسخة النافذة المرخصة وتوثيق رقم الإصدار/السنة في تقرير أساس التصميم. قائمة أسماء الكودات على موقع المجلس لا تكفي لإثبات الامتثال.

10. الدفاع المدني والسلامة من الحريق

الدفاع المدني يدقق المخططات الهندسية ويكشف المبنى وأنظمة الوقاية والحماية الذاتية، وتدخل موافقته في مسار إذن الأشغال ورخصة المهن. يجب إدخاله من التصميم المفهومي، لأن المستشفى يتطلب استراتيجية إخلاء مرحلي أفقي ورأسي واستمرارية مرضى لا يستطيعون الإخلاء الذاتي.

الحزمة	المحتوى المطلوب	دليل القبول
استراتيجية الحريق	تصنيف الإشغال، أحمال، قطاعات دخان/حريق، إخلاء مرحلي، مناطق لجوء، مقاومات، مخارج وسلالم ومصاعد حريق عند الانطباق.	تقرير ومخطط معتمد.
الإنذار والكشف	لوحة معنونة، كواشف، نقاط نداء، صفارات/ومضات، ربط مصاعد وأبواب وHVAC وغازات ومولدات، مراقبة أعطال.	اختبار cause-and-effect كامل.
المكافحة	رش آلي/خراطيم/مطافئ/هيدرنت/مضخات وخزان بحسب الحسابات، مطابخ وغرف خطرة وحماية خاصة.	حسابات هيدروليكية واختبار تدفق وضغط.
الدخان	سحب دخان/ضغط سلالم وممرات أو حلول الكود، إيقاف/تشغيل مراوح وdampers.	اختبار وظيفي وقراءات.
الإنارة والإشارات	إنارة طوارئ، علامات خروج واتجاه، لوحات وخطط، مصدر احتياط.	اختبار زمن واستمرارية.
وصول فرق الإنقاذ	طرق وصول، ساحات، بوابات، ارتفاعات، نقاط ماء ومعلومات/غرفة تحكم.	كشف موقعي دون عوائق.
التشغيل	فريق سلامة، خطط وإخلاء، تدريب ومناورات، تصاريح أعمال ساخنة، فحص وصيانة وسجلات.	محاضر تدريب وتجارب دورية.

منع خطأ شائع

لا يجوز أخذ موافقة مخطط دفاع مدني ثم تغيير الأبواب أو التقسيمات أو الأسقف أو وظيفة الغرف دون مراجعة أثر الحريق. الكشف النهائي يقارن الواقع بالمخطط المعتمد، وأي اختلاف قد يمنع توصية إذن الأشغال.

11. البيئة والنفايات الطبية والصرف

11.1 القرار البيئي

- تقديم وصف موقع ونطاق شامل لوزارة البيئة للحصول على قرار التصنيف والمتطلبات قبل الإنشاء؛ لا تفترض أن جميع المستشفيات في الفئة نفسها.
- يشمل الوصف: الأسرة، الأقسام، حركة المركبات، الوقود، المولدات، الأكسجين والغازات، الأشعة/الطب النووي، المختبر، الكيماوي، النفايات، الصرف، أي محطة معالجة أو محرقة.
- تنفيذ شروط القرار في وثائق العطاء والمخططات، وإثباتها في الاستلام والتشغيل.
- أي إضافة لاحقة ذات أثر بيئي تُراجع قبل التنفيذ؛ ترخيص المستشفى لا يلغي الترخيص البيئي.

11.2 تعليمات إدارة النفايات الطبية لسنة 2024

تعليمات 2024 نافذة من تاريخ نشرها وتلغي تعليمات إدارة النفايات الطبية رقم 1 لسنة 2001. يجب تحديث جميع المخططات والسياسات والألوان والعقود على هذا الأساس [ب-05].

نوع النفايات	اللون/الوعاء الوارد في تعليمات 2024	ملاحظة تشغيلية
معدية وتشريحية	أصفر، كيس/عبوة تحمل إشارة الخطر البيولوجي	فرز عند نقطة التولد؛ يمنع إعادة الفرز اليدوي.
شديدة العدوى	أحمر، كيس/عبوة مناسبة للتعقيم وتحمل إشارة الخطر	مسار ومعالجة خاصة وفق الخطة والجهة المعتمدة.
أدوات حادة	عبوة صلبة غير نافذة/غير قابلة للثقب، أصفر أو أحمر بحسب الخطورة	تغلق عند خط الامتلاء ولا يُعاد فتحها.
كيميائية وفلزات ثقيلة	بني أو العبوة الأصلية/عبوة متوافقة	فصل المواد غير المتوافقة ووضع بطاقة الخطر.
دوائية/صيدلانية	بني أو العبوة الأصلية	إدارة منتهيات ومخدرات ومرتجعات بمسارات موثقة.
سامة للجينات/علاج كيماوي	أزرق مع إشارة الخطر وعبارة نفايات علاج كيماوي	PPE وانسكاب ونقل/معالجة معتمدة.
مشعة	وعاء/درع رصاصي وإشارة الخطر الإشعاعي وفق هيئة الطاقة والمعادن	لا تدخل مسار النفايات الطبية العادي.
طبية غير خطرة	أسود	تعامل كنفايات بلدية ما لم تتلوث.

11.3 البنية التشغيلية الإلزامية للنفايات

- خطة إدارة نفايات تغطي التولد والفرز والعبوات والجمع الداخلي والتخزين والنقل والمعالجة والتخلص والطوارئ.
- لجنة متابعة لإدارة النفايات تضم الإدارة، الصحة العامة/العدوى، ضابط النفايات، التمريض، الصيدلة، المختبر، الأشعة، الخدمات، التزويد والأمن بحسب التعليمات.
- غرفة تخزين مؤمنة قابلة للتنظيف والغسل والتهوية، بعيدة عن الغذاء والجمهور، مع وصول مركبة النقل دون عبور نظيف.
- عقود مع ناقل/معالج مصرح، وثائق استلام وتسليم (manifest)، أوزان حسب القسم والنوع، وسجلات المعالجة والتخلص.
- تقارير شهرية لمديرية صحة البيئة بكمية النفايات المتولدة ومكان المعالجة، حسب تعليمات 2024.
- تطعيم وفحص وتدريب وPPE للعاملين، وسجل وخز وإصابات وانسكابات واستجابة فورية.
- فحص كفاءة التعقيم دورياً ومؤشرات بيولوجية وسجلات؛ إرسال النتائج للجهة المعنية وفق التعليمات.

12. العمل والكوادر والضمان الاجتماعي

12.1 متطلبات وزارة الصحة للكادر

المطلب	الحد/القاعدة	الإثبات
المدير العام	طبيب مزاول للمهنة ومسؤول عن الشؤون الإدارية والمالية والفنية والطبية.	قرار تعيين ومزاولة وعقد ووصف وظيفي.
المدير الإداري	مؤهل جامعي أول على الأقل.	شهادة مصدقة وعقد.

المطلب	الحد/القاعدة	الإثبات
المدير الفني	طبيب مسؤول عن النواحي الطبية والعلاجية والكادر الطبي.	مزاولة واختصاص وقرار.
الأطباء الأردنيون	لا يقلون عن 90% من مجموع الأطباء العاملين.	قائمة محسوبة وجنسيات ومزاولات كل ستة أشهر.
العاملون غير الأطباء الأردنيون	لا يقلون عن 80% من مجموع غير الأطباء.	قائمة محسوبة وعقود وتصاريح.
الامتياز والإقامة الأردنيون	لا يقلون عن 75% من المقبولين في الفئتين.	سجلات برامج واعتمادات.
مزاولات المهن	سارية لكل مهنة صحية وتجدد وفق التشريعات والتطوير المهني المستمر.	نسخ رقمية وتواريخ تنبيه ومسار CPD.
التغطية	عمل المستشفى وخدماته الحرجة على مدار 24 ساعة بحسب النظام والبرنامج.	روستر فعلي وخطة بديل و-on call.

12.2 السلامة والصحة المهنية

- تطبيق قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته وأنظمة 2023 للسلامة والصحة المهنية، الوقاية من الأخطار، والرعاية الطبية الوقائية والعلاجية للعاملين.
- إجراء تقييم مخاطر موثق لكل نشاط: وخز وإصابات، مواد كيماوية وعلاج كيماوي، إشعاع، عدوى، رفع ونقل، ضوضاء، حرارة، كهرباء، غازات، حريق وعنف مهني.
- تعيين مشرفي سلامة وتشكيل اللجان حسب حجم المنشأة ودرجة الخطورة؛ إذا بلغ الفرع 50 عاملاً فأكثر تُشكّل لجنة سلامة وصحة مهنية وفق نظام 33 لسنة 2023.
- فحوص أولية ودورية وتطعيمات وسجلات إصابات وأمراض مهنية، معدات وقاية، تدريب وطوارئ، ومراقبة المتعهدين.
- تصاريح عمل سارية لغير الأردنيين قبل المباشرة، مع مراعاة نسب التشغيل الواردة في نظام المستشفيات.
- شمول المنشأة والعاملين بالضمان الاجتماعي منذ بدء العلاقة الخاضعة.

> تحديث تشغيلي 2026
>
> وزارة العمل تنشر أدلة تصاريح محدثة، ومنها دليل شامل جرى تحديثه في 2026/08/20 ودليل للمهارات المتخصصة. إذا كان المشروع سيستقدم كوادر غير أردنية، يُراجع الدليل والنسب والوثائق في تاريخ الطلب قبل إصدار عروض العمل.

13. الحوكمة واللجان والسياسات قبل الافتتاح

اللجنة/المنظومة	التشكيل/الوظيفة الأساسية	الحد الأدنى من المخرجات
اللجنة الفنية	رؤساء الأقسام الرئيسية مع المدير الفني والإداري ورئيسي الصيدلة والتمريض وفق النص المعدل.	نظام داخلي، إدخال/خروج، دوام 7/24، إشعاع وعدوى، كوارث وإخلاء، غذاء، زي.
لجنة الوفيات	ثلاثة أطباء اختصاص لدراسة الوفيات وأسبابها.	اجتماعات وتحليل واتجاهات وإجراءات تصحيحية.
لجنة الجودة	ثلاثة أشخاص على الأقل وفق النظام.	مؤشرات، تدقيق، شكاوى، أحداث جسيمة، تحسين.

اللجنة/المنظومة	التشكيل/الوظيفة الأساسية	الحد الأدنى من المخرجات
لجنة مكافحة العدوى	طبيب اختصاص + ممرض ذو خبرة في مكافحة العدوى + صيدلي وفق تعديل 2022.	برنامج IPC، ترصد، تدقيق يد، عزل، مضادات، تفشٍ وتقارير.
لجنة إدارة النفايات	تشكيل متعدد الأقسام وفق تعليمات 2024.	خطة، تدريب، أوزان، manifests، معالجة، إصابات وتقارير شهرية.
لجنة السلامة والصحة المهنية	حسب نظام العمل 2023/33 وحجم المنشأة.	تقييم مخاطر، اجتماعات، إصابات، تدريب وتصحيح.
لجنة الأدوية والعلاجات	وفق نطاق الممارسة ومتطلبات الجودة.	قائمة دوائية، استخدام رشيد، high-alert، تفاعلات، نقص واستدعاء.
إدارة الطوارئ والكوارث	قيادة حادث ومناوبون واتصال مع الجهات.	خطة all-hazards، إخلاء، mass casualty، استمرارية وتمارين.

13.1 حزمة السياسات التي يجب أن تكون جاهزة للكشف

المجموعة	الموضوعات
سريرية	القبول والخروج والتحويل، تقييم المريض، الموافقة المستنيرة، الجراحة الآمنة، التخدير، الدواء، نقل الدم، الإنعاش، العناية، العزل، الولادة/المولود عند الانطباق.
سلامة	الحريق والإخلاء، المواد الخطرة، الغاز الطبي، الإشعاع، الأمن، الطفل/المفقود، العنف، الانقطاع، الكوارث، الإبلاغ عن الحوادث.
عدوى	نظافة اليدين، PPE، العزل، التعقيم والتطهير، الأدوات، النفايات، تنظيف البيئة، التفشي، التعرضات المهنية، المضادات.
إدارية وحقوق	حقوق وواجبات المريض، الشكاوى، الخصوصية، الأسعار والفواتير، السجلات والحفظ، اللغة/الإتاحة، الإعلان، إدارة العقود.
هندسية	الصيانة، المعايرة، إدارة الأصول، المولد وUPS، المياه، HVAC، المصاعد، الحريق، الغازات، shutdown permits، الأعمال الساخنة.
استمرارية وأمن سيبراني	النسخ والاستعادة، توقف HIS، هجوم سيبراني، الاتصال البديل، الأولويات السريرية، اختبار الاستعادة.

14. الاختبارات والتشغيل التجريبي قبل الكشف

النظام	الاختبار الأدنى	سجل التسليم
المعماري	قياس المساحات والعروض والارتفاعات، الأبواب، الإتاحة، التشطيبات، اللافتات، مطابقة الغرف للاستعمال.	جدول قياس as-built وصور ومخططات مختومة.

النظام	الاختبار الأدنى	سجل التسليم
الحريق	إنذار كامل وتكامل، مضخات وتدفق، رش/خراطيم، أبواب ودخان، إنارة، مولد، مصاعد، kitchen suppression.	محاضر وتوصية الدفاع المدني.
الكهرباء	عزل، تأريض، قصر وانتقائية، UPS، ATS، مولد بنك حمل، الأحمال الحرجة، انقطاع كامل.	تقارير اختبار وشهادات معايرة ورسومات.
الغازات الطبية	ضغط وتسريب ونقاوة وتداخل وتعريف، valves/alarms، المصدر والاحتياط، انقطاع.	شهادة طرف مؤهل وخريطة مناطق.
HVAC	TAB، ضغط واتجاه هواء، حرارة/رطوبة، HEPA عند الانطباق، إنذارات وتكامل حريق.	تقرير TAB/commissioning ومصفوفة تحقق.
المياه والصرف	ضغط وجودة، خزانات، مياه ساخنة، ارتجاع، صرف، معالجة خاصة، انقطاع.	تحاليل ومخططات وسجل تنظيف وخطة.
الأشعة	قبول المصنع، مسح تدريع، interlocks، جودة وصورة وجرعة، معايرة.	موافقة/رخصة هيئة الطاقة والمعادن وتقارير الفيزياء.
الأجهزة الطبية	قبول وسلامة كهربائية وأداء ومعايرة واتصال، labeling وسجل أصول.	شهادات قبول ومعايرة وتدريب.
CSSD	IQ/OQ/PQ، مؤشرات كيميائية وبيولوجية، جودة المياه، التتبع والاستدعاء.	حزمة تأهيل وسجلات دورات.
IT/اتصالات	حسابات وصلاحيات، نداء، downtime، code blue، نسخ واستعادة، طباعة هوية وباركود.	نتائج UAT وDR test وخطط توقف.
تشغيلي	رحلة مريض كاملة، كود أزرق، حريق، حادث جماعي، انقطاع كهرباء/ماء/غاز، طفل مفقود، تسرب كيماوي.	محاضر تمارين وإغلاق الملاحظات.

14.1 قاعدة إقفال الملاحظات

- كل ملاحظة لها رقم، موقع، مصدر، درجة خطورة، مسؤول، موعد، دليل إغلاق، وموافق على الإغلاق.
- لا تُغلق الملاحظة بصورة فقط إذا كانت تتطلب اختباراً أو شهادة أو مخططاً معدلاً.
- الملاحظات التي تغير الرخصة أو الحريق أو الاستخدام لا تُغلق داخلياً؛ تحتاج موافقة الجهة.
- قبل طلب كشف وزارة الصحة، ينفذ فريق المالك كشفاً وهمياً باستخدام نفس هذا الدليل ويغلق جميع البنود الحرجة.

15. إذن الأشغال والترخيص النهائي

15.1 ملف إذن الأشغال

الوثيقة/الإجراء	جهة الإصدار/المراجعة	شرط القبول
رخصة البناء وملاحقها	الأمانة/البلدية	سارية، كل التعديلات مصدقة، لا مخالفات غير مسوّاة.
مخططات كما نُفذ	المكتب الهندسي/الجهة التنظيمية	مطابقة للواقع وللموافقات.

الوثيقة/الإجراء	جهة الإصدار/المراجعة	شرط القبول
إقرار/شهادة إشراف وتنفيذ	المهندس/المقاول والجهة المختصة	وفق القانون والنظام المحلي.
توصية الدفاع المدني	إدارة الوقاية والحماية الذاتية	الكشف وإغلاق الملاحظات واختبار الأنظمة.
مصاعد وخدمات	الجهات المختصة	فحص وشهادة تشغيل وربط آمن.
بيئة وصرف	وزارة البيئة/المياه/الصرف	تنفيذ الشروط وربط/تصريف قانوني.
كشف مطابقة	الأمانة/البلدية	الاستعمال والمساحات والارتدادات والمواقف والواجهات والخدمات مطابقة.

خارج أمانة عمّان تختلف أسماء النماذج ومسار المعاملة بين البلديات، لكن المبدأ ثابت: لا يُستخدم المبنى كمستشفى قبل إثبات مطابقة المنفذ للرخصة وحصوله على إذن أشغال/إشغال من الجهة المختصة. داخل عمّان تُدار خدمات تراخيص الأبنية وإذن الأشغال إلكترونياً مع ربط جهات مثل نقابة المهندسين والمقاولين والدفاع المدني ودائرة الأراضي [ب-03].

15.2 ملف الجاهزية النهائي لوزارة الصحة

- طلب كشف جاهزية نهائي ونسخة الموافقة المبدئية ضمن مدتها.
- إذن الأشغال ورخصة البناء والمخططات النهائية المعتمدة من الأمانة/البلدية والدفاع المدني.
- سند/عقد الموقع وشهادات تسجيل الكيان والتفويض، وأي تحديثات ملكية أو اسم.
- جدول الأسرة والغرف والأقسام مطابق للواقع، وقائمة الأجهزة والتجهيزات.
- تراخيص الصيدلية والمختبر والأشعة والوحدات التخصصية وسيارات الإسعاف.
- قوائم الكادر والمزاولات والتغطية والنسب والتعيينات الإدارية والفنية.
- اللجان والسياسات وخطط الطوارئ والعدوى والنفايات والجودة والصيانة.
- قائمة الأسعار المقترحة للاعتماد وآلية الإعلان المسبق والفواتير التفصيلية.
- نظام الملف الطبي الإلكتروني واختبارات النسخ والاستعادة والحفظ.
- حزم commissioning واختبارات الأنظمة الطبية والهندسية وتدريب المستخدمين.

16. الالتزامات بعد التشغيل والتجديد

الالتزام	الدورية/الحدث	ضابط التحكم
تجديد ترخيص المستشفى	كل خمس سنوات	بدء ملف التجديد قبل 6 أشهر؛ تدقيق الإنذارات والاعتماد والرسوم.
قائمة العاملين	كل ستة أشهر	استخراج موحد من HR والتحقق من المزاولات والنسب قبل الإرسال.
الأسعار	قبل السريان وكل تعديل	موافقة الوزير/الوزارة، إعلان مسبق للمريض، فواتير تفصيلية.
تغيير النوع/التخصص/الأسرة/المبنى/الطابق	قبل التغيير	طلب وموافقة مسبقة؛ لا تنفيذ ثم تصويب.
إضافة وحدة تخصصية	قبل التصميم/الشراء/التشغيل	تعليمات الوحدة وكتاب موافقة وكشف وترخيص.

الالتزام	الدورية/الحدث	ضابط التحكم
السجلات الطبية	مستمر	إلكترونية؛ حفظ 10 سنوات على الأقل من آخر إدخال، واستثناء القضايا من الإتلاف.
وثائق لجنة المسؤولية الطبية	عند الطلب	تقديم الملف/التقرير/الفاتورة والوثائق خلال أسبوع وفق التعديل.
النفايات الطبية	يومي/شهري	فرز وتتبع وعقود؛ تقرير شهري للكميات ومكان المعالجة.
الحريق والطوارئ	اختبارات دورية ومناورة سنوية على الأقل وفق الخطة/الجهة	سجل فحص وصيانة ومناورات وإغلاق.
الأشعة	حسب الرخصة والهيئة	تجديد مؤسسي/شخصي، جرعات، QC، مسح وتبليغ.
السلامة المهنية	مستمر ودوري	تقييم مخاطر، لجنة، إصابات، فحوص، تدريب، تصاريح.
الصيانة والمعايرة	حسب المخاطر والمصنع والكود	CMMS، نسب إكمال، أجهزة متأخرة، تعطيل آمن.

17. قائمة التحقق الرئيسية للمالك ومدير المشروع

A — قبل شراء/استئجار الأرض

- ● □ نوع المستشفى والسعة والخدمات محددة.
- ● □ استعمال المستشفى مقبول كتابياً من التنظيم.
- ● □ المواقف النظامية قابلة للتحقيق داخل الحل المعتمد.
- ● □ مدخل/مخرج منفصلان وساحات مسورة ومسار إسعاف/دفاع مدني قابل للتنفيذ.
- ● □ مياه 250 م³ على الأقل وصرف وقدرة كهرباء قابلة للتحقيق.
- ● □ قرار/مسار التصنيف البيئي معروف.
- ● □ القيود والرهون وحق الإشغال والمدة التعاقدية مدققة قانونياً.

B — قبل الموافقة المبدئية للصحة

- ● □ أهلية مقدم الطلب وتسجيل الشركة والغايات مكتملة.
- ● □ مخطط تنظيمي وسند حديثان.
- ● □ برنامج طبي وجدول أسرة وأقسام معتمد داخلياً.
- ● □ المخطط يحقق المساحات والارتفاعات والممر 2.40 م والمواقف والساحات.
- ● □ الوحدات التخصصية محددة ولم تُخفَ عن الطلب.
- ● □ تاريخ انتهاء الموافقة المبدئية سيدار في سجل المخاطر.

C — قبل رخصة البناء

- ● □ تقرير أساس تصميم وكودات نافذة.
- ● □ اعتماد مخططات الدفاع المدني.
- ● □ تدقيق النقابة/الجهات الهندسية.
- ● □ موافقة البيئة وشروطها مدمجة.
- ● □ تدريع الأشعة معتمد قبل صب/إغلاق الإنشاء.

- ● □ جداول غرف وHVAC وطاقة وغازات وأجهزة متناسقة.
- ● □ تغييرات الصحة المبدئية مدمجة في كل التخصصات.

D — قبل إغلاق الأعمال المخفية

- ● □ فحص الحواجز المقاومة للحريق والاختراقات.
- ● □ فحص الغاز الطبي واللحام والضغط.
- ● □ فحص التدريع والتأريض والأنظمة داخل الجدران.
- ● □ صور وإحداثيات as-built للأعمال المخفية.
- ● □ اعتماد أي تغيير غرف/أبواب/مخارج/أسقف قبل تنفيذه.

E — قبل إذن الأشغال

- ● □ لا مخالفات على رخصة البناء.
- ● □ جميع أنظمة الحريق مختبرة ومربوطة.
- ● □ المصاعد والخدمات مفحوصة.
- ● □ المواقف والمداخل والساحات منفذة بلا عوائق.
- ● □ مخططات as-built وشهادات الإشراف جاهزة.
- ● □ توصية الدفاع المدني صادرة.

F — قبل كشف وزارة الصحة

- ● □ إذن الأشغال والمخططات المختومة متاحة.
- ● □ غرف وأسرّة وأقسام مطابقة للترخيص.
- ● □ الصيدلية والمختبر والأشعة والوحدات وسيارات الإسعاف مرخصة/موافق عليها.
- ● □ الكادر والتغطية والمزاولات والنسب مكتملة.
- ● □ اللجان والسياسات وخطط الطوارئ والنفايات والعدوى فعالة.
- ● □ اختبارات commissioning وإغلاق الملاحظات مكتملة.
- ● □ الأسعار ونظام الملف الطبي الإلكتروني جاهزان.

G — قبل استقبال أول مريض

- ● □ الترخيص النهائي مستلم.
- ● □ إذن مباشرة العمل من الوزير مستلم.
- ● □ جميع التراخيص الفرعية سارية.
- ● □ مناوبات 7/24 ومركبات الإسعاف ومخزون الطوارئ جاهزة.
- ● □ تدريب ومحاكاة رحلة المريض والطوارئ مكتملان.
- ● □ يوم الافتتاح لا يتضمن خدمات لم تُذكر في الترخيص.

18. أخطاء عالية الخطورة تؤدي إلى إعادة التصميم أو رفض الكشف

الخطأ	الأثر	الإجراء الوقائي
شراء موقع قبل تثبيت استعماله ومواقفه	استحالة تحقيق الترخيص أو كلفة أرض إضافية.	كتاب تنظيم + دراسة كتلة ومواقف قبل الالتزام.
اعتبار الموافقة المبدئية رخصة بناء أو تشغيل	مخالفة وتوقف المشروع.	إدارة بوابات مستقلة ومخرجات مكتوبة.

الخطأ	الأثر	الإجراء الوقائي
الاعتماد على مسودة 2022 القديمة	استخدام مدة 3 سنوات أو رسوم غير نهائية.	اعتماد النظام النهائي رقم 2022/63: خمس سنوات ورسومه الحالية.
إعطاء غرفة العمليات رقماً غير رسمي	خلاف مع اللجنة أو عدم ملاءمة الجهاز.	اعتماد خطي لمساحة كل نوع غرفة وفق الجهاز والخدمة.
خفض صافي الممر/السقف بعد MEP	عدم مطابقة بعد الإنجاز.	تنسيق BIM/كشف تعارض وقياس صافي قبل الإغلاق.
تركيب جهاز أشعة قبل اعتماد التدريع	رفض، إعادة بناء، خطر جرعات.	اعتماد هيئة الطاقة والمعادن قبل الشراء والتنفيذ.
تغيير المخطط المعتمد أثناء الموقع	رفض الدفاع المدني/إذن الأشغال/الصحة.	نظام RFI/تغيير مع تقييم ترخيص وموافقة مسبقة.
تأجيل تراخيص الصيدلية والمختبر والوحدات	تعطل الافتتاح رغم جاهزية المبنى.	مسارات ترخيص متوازية منذ 9–12 شهراً قبل الافتتاح.
commissioning ورقي دون اختبارات تكامل	فشل أثناء الكشف أو عند أول طارئ.	سيناريوهات انقطاع وتكامل موقعة وموثقة.
تصنيف تعليمات النفايات 2001 كمرجع حالي	سياسات وألوان وسجلات قديمة.	اعتماد تعليمات 2024 التي ألغت تعليمات 2001.
تشغيل ناعم قبل إذن المباشرة	مخالفة صريحة حتى لو كان بعدد مرضى محدود.	لا استقبال علاجي قبل الوثيقتين النهائيتين.

19. برنامج زمني مرجعي قائم على البوابات

المدد أدناه أداة إدارة وليست مدد خدمة حكومية ملزمة. تُعدل حسب حجم المستشفى والموقع وتعقيد الوحدات وسرعة إقفال الملاحظات.

الفترة المرجعية	الهدف	بوابة الخروج
0–3 أشهر	نطاق، كيان، موقع، فحوص أولية، برنامج طبي	قرار موقع موثق وعدم وجود مانع جوهري.
2–6 أشهر	مخطط مفهومي وطلب صحة وملاحظات	موافقة مبدئية للصحة وسجل شروط.
5–12 شهراً	تصميم تفصيلي وتدقيقات وبيئة وحريق وإشعاع	مخططات معتمدة ورخصة بناء.
10–30 شهراً	إنشاء وتوريد مع ضبط تغييرات	إنجاز مادي مطابق وأعمال مخفية موثقة.
24–34 شهراً	تركيب واختبارات وتشغيل تجريبي	حزم commissioning وإغلاق عيوب.
30–36 شهراً	إذن أشغال وتراخيص فرعية وكادر وسياسات	جاهزية ملف الكشف الصحي.
34–38 شهراً	كشف الصحة وإقفال الملاحظات والرسوم	ترخيص نهائي وإذن مباشرة.

الفترة المرجعية	الهدف	بوابة الخروج
بعد الافتتاح	استقرار، قياس، تجديدات	امتثال مستمر ومراجعة ربع سنوية داخلية.

قيد الخمس سنوات

مهما كان البرنامج الداخلي، تاريخ الموافقة المبدئية هو القيد القانوني الحرج. إذا اقترب المشروع من نهايتها دون اكتمال الإنشاء، لا تفترض إمكان تمديدها؛ اطلب موقفاً خطياً مبكراً من الوزارة وخطة بديلة.

20. توزيع المسؤوليات داخل فريق المشروع

الدور	المسؤولية التي لا تفوض عملياً	المخرج
المالك/مجلس الإدارة	النطاق والتمويل والموقع والقرارات والتعيينات والتعهدات.	Project brief وقرارات وميزانية امتثال.
مدير مشروع الترخيص	سجل الجهات والكتب والمواعيد والاشتراطات والتغييرات.	Master approvals register.
المخطط الطبي	البرنامج الطبي وتدفقات وأعداد وأجهزة وعلاقات.	Room data sheets وجدول الأسرة.
الاستشاري المعماري	دمج المتطلبات والمساحات والإتاحة والحركة والتنسيق.	مخططات معتمدة ومصفوفة مطابقة.
MEP/إنشائي/حريق	الحسابات والكودات والتنسيق والاختبارات.	Basis of design وتقارير وحزم commissioning.
استشاري الأشعة/الفيزياء	التدريع والترخيص والمسح والجودة.	تقارير معتمدة ورخص.
المقاول	تنفيذ مطابق، ضبط جودة، as-built واختبارات وتدريب.	ملف تسليم كامل لا مجرد إنجاز مادي.
فريق التشغيل السريري	السياسات والكادر والتدريب والمحاكاة وقبول الأجهزة.	Operational readiness evidence.
مسؤول الجودة/الامتثال	التدقيق الداخلي وإغلاق الملاحظات والتجديدات.	لوحة امتثال وتقارير.
المستشار القانوني	ملكية وعقود وتشريعات وإعلانات وأسعار ومسؤولية.	Legal register ومراجعة وثائق.

21. سجل التحديثات ونقاط المراقبة

التحديث	التاريخ/المرجع	الأثر
تعديل نظام المستشفيات الخاصة	نظام 2022/63؛ الجريدة 5825؛ 2022/11/16	الموافقة خمس سنوات، تحديث المبنى والأقسام والرسوم والسجلات.

التحديث	التاريخ/المرجع	الأثر
تعليمات غسيل الكلى الخاصة	الجريدة 5930؛ 2024	ملف مستقل للوحدة والكادر والمياه والتشغيل.
تعليمات الإخصاب/أطفال الأنابيب	الجريدة 5954؛ 2024	ملف مستقل للوحدة والخصوصية والسجلات والتشغيل.
تعليمات إدارة النفايات الطبية	2024؛ منشورة بوزارة الصحة	تلغي 2001؛ ألوان وسجلات ولجنة وتقارير شهرية.
تنظيم عمّان	تعديل 2025/13 ونظام تخطيط 2025/81	يجب استخدام النص الحالي للموقع داخل الأمانة.
دليل خدمات الصحة	الإصدار الثاني 2026	إجراءات ورسوم وقنوات حالية.
الملف الطبي الإلكتروني	مهلة خمس سنوات من تعديل 2022	موعد حرج 2027/11/16 ما لم يعدل.
البيئة	تشاور/تحديث ملاحق ظهر في 2026	إعادة التحقق من الجريدة الرسمية وقرار التصنيف قبل التقديم.
تصاريح العمل	أدلة محدثة حتى 2026/08/20	إعادة التحقق قبل استقدام غير الأردنيين.

21.1 بروتوكول تحديث هذا الدليل

- قبل تقديم أي معاملة: بحث باسم التشريع ورقمه في الجريدة الرسمية وصفحة الوزارة المختصة.
- حفظ نسخة PDF مؤرخة من كل نص واعتماد، مع رقم العدد والصفحة/الرابط.
- مقارنة النص المعدل بالنص الأصلي وإنشاء نسخة موحدة داخلية يراجعها المستشار القانوني.
- تحديث مصفوفة الأثر: المخططات، العقود، الأجهزة، الكادر، الرسوم والبرنامج.
- إصدار نشرة تغيير لجميع التخصصات ومنع استخدام نسخة قديمة بعد تاريخ السريان.

22. المراجع الرسمية وروابط التحقق

الأولوية للنسخة المنشورة في الجريدة الرسمية ثم النص/الدليل المنشور على موقع الجهة المختصة. تاريخ الوصول والتحقق: 2026/09/26.

[ص-01] — نظام المستشفيات الخاصة رقم 54 لسنة 2014 وتعديلاته — وزارة الصحة/العدد 5286

مرجع الأحكام الأساسية؛ صفحة الجريدة الرسمية تؤكد النشر، ووزارة الصحة توفر نسخة مجمعة سابقة لتعديل 2022.

https://pm.gov.jo/Ar/Pages/NewsPaperDetails/5286

[ص-02] — نظام معدل لنظام المستشفيات الخاصة رقم 63 لسنة 2022 — العدد 5825

النص المعدل النافذ؛ نُشر 2022/11/16.

https://www.pm.gov.jo/Ar/Pages/NewsPaperDetails/5825

[ص-03] — دليل خدمات وزارة الصحة — الإصدار الثاني 2026

الإجراءات والوثائق والرسوم وقنوات تقديم خدمات الترخيص.

https://www.moh.gov.jo/EBV4.0/Root_Storage/AR/Announcement/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%_84D8%B5%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_20%pdf.26

[ص-04] — تعليمات إنشاء وحدات غسيل الكلى لدى المستشفيات الخاصة لسنة 2024

منشورة في العدد 5930 من الجريدة الرسمية.

https://www.pm.gov.jo/Ar/Pages/NewsPaperDetails/5930

[ص-05] — تعليمات إنشاء وحدات الإخصاب/أطفال الأنابيب لدى المستشفيات الخاصة لسنة 2024

منشورة في العدد 5954 من الجريدة الرسمية.

https://www.pm.gov.jo/Ar/Pages/NewsPaperDetails/5954

[ب-01] — مجلس البناء الوطني الأردني — الكودات الوطنية

القائمة الرسمية للكودات الفنية؛ يلزم الرجوع إلى النسخ النافذة الكاملة.

https://jnbc.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9

[ب-02] — أمانة عمّان الكبرى — التشريعات

تتضمن نظام التخطيط والتنظيم 2025/81 وتعديل الأبنية والتنظيم 2025/13.

https://media.ammancity.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%DB9%D8%A7%D8%AA%8

[ب-03] — أمانة عمّان — خدمات تراخيص الأبنية وإذن الأشغال والربط الإلكتروني

مرجع إجرائي لمسار الأبنية داخل عمّان.

https://media.ammancity.gov.jo/Ar/NewsDetails/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8B9%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82__%D8%AD%D8%B2%D9%%D8%A9_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%85D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8_A8%D9%86%D9%8A%D8%A9%

[ب-04] — الدفاع المدني — تدقيق المخططات الهندسية

اعتماد مخططات الوقاية والحماية الذاتية.

https://psd.gov.jo/ar-jo/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%87-D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82-%85%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%/D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9%

[ب-05] — تعليمات إدارة النفايات الطبية لسنة 2024 — وزارة الصحة

النص الحالي الذي ألغى تعليمات 2001.

https://www.moh.gov.jo/ebv4.0/root_storage/ar/eb_list_page/%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9.pdf

[ب-06] — وزارة البيئة — الأنظمة

نظام التصنيف والترخيص البيئي وملاحقه، ونظام إدارة المواد والنفايات الخطرة.

https://moenv.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9

[ت-01] — هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن — قطاع العمل الإشعاعي

الرخص المؤسسية والشخصية والتشريعات للممارسات الطبية الإشعاعية.

https://emrc.gov.jo/AR/Pages/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84_%D8%A7%D9%84%DA7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9%D9%8A%8

[ت-02] — هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن — الخدمات الإلكترونية

قائمة خدمات إصدار وتجديد الرخص المؤسسية للممارسات الإشعاعية.

https://www.emrc.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9%

[ع-01] — وزارة العمل — القوانين

قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته.

https://www.mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D86%9

[ع-02] — وزارة العمل — الأنظمة

أنظمة السلامة والصحة المهنية 31 و32 و33 لسنة 2023.

https://www.mol.gov.jo/AR/List/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9

[ع-03] — المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي — تسجيل منشأة

خدمة شمول/تسجيل المنشأة.

https://eservices.ssc.gov.jo/corporateRegisteration

[ش-01] — دائرة مراقبة الشركات — تسجيل شركة جديدة

تأسيس الكيان والحصول على شهادة التسجيل.

https://ccd.gov.jo/AR/Pages/%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%8A%D9%84_%D8%B4%D8%B1%DD8%A9_%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%83%9

[م-01] — وزارة الصحة — مسار التطوير المهني المستمر

يربط استيفاء الساعات بتجديد رخصة مزاولة المهن الصحية.

https://masar.moh.gov.jo/

[د-01] — وزارة الصحة — ترخيص المهن والمؤسسات الصحية

بوابة المديرية والخدمات ذات العلاقة.

https://www.moh.gov.jo/AR/Pages/%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D9%8A%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%%84D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9

23. نماذج عمل جاهزة للاستخدام داخل المشروع

23.1 سجل الموافقات

الرقم	الجهة/الموافقة	تاريخ الطلب	الحالة/الملاحظات
AP-001	وزارة الصحة — موافقة مبدئية	__/__/_____	
AP-002	البلدية/الأمانة — تنظيم واستعمال	__/__/_____	
AP-003	الدفاع المدني — مخططات	__/__/_____	
AP-004	وزارة البيئة — قرار تصنيف/ترخيص	__/__/_____	
AP-005	رخصة البناء	__/__/_____	
AP-006	إذن الأشغال	__/__/_____	
AP-007	ترخيص إشعاعي	__/__/_____	
AP-008	صيدلية/مختبر/وحدات	__/__/_____	
AP-009	ترخيص نهائي وإذن مباشرة	__/__/_____	

23.2 سجل الملاحظات

الملاحظة/المصدر	المسؤول والموعد	دليل الإغلاق
رقم: _____ / الجهة: _____ / الموقع: _____ / الوصف: _____	المسؤول: _____ الموعد: __/__/_____ الخطورة: □حرج □عالٍ □متوسط	□ صورة □ اختبار □ شهادة □ مخطط معتمد وافق على الإغلاق: _____

الملاحظة/المصدر	المسؤول والموعد	دليل الإغلاق
رقم: _____ / الجهة: _____ / الموقع: _____ / الوصف: _____	المسؤول: _____ الموعد: __/__/____ الخطورة: □حرج □عالٍ □متوسط	□ صورة □ اختبار □ شهادة □ مخطط معتمد وافق على الإغلاق: _____
رقم: _____ / الجهة: _____ / الموقع: _____ / الوصف: _____	المسؤول: _____ الموعد: __/__/____ الخطورة: □حرج □عالٍ □متوسط	□ صورة □ اختبار □ شهادة □ مخطط معتمد وافق على الإغلاق: _____

23.3 محضر اجتماع ما قبل التصميم مع الجهات

- المشروع/الموقع/السعة/النوع: _____
- الأقسام والوحدات الخاصة: _____
- الحضور والصفة والجهة: _____
- القيم الرقمية المؤكدة: _____
- المتطلبات التي تحتاج كتاباً أو تعليمات: _____
- المخططات/الوثائق المطلوب تقديمها: _____
- القرارات ومسؤول كل إجراء وتاريخه: _____
- التوقيعات/رقم الكتاب المرجعي: _____

خاتمة تنفيذية

أقصر طريق لترخيص مستشفى خاص ليس البدء بالرسم أو الإنشاء، بل تثبيت النطاق والموقع والبرنامج الطبي، ثم جعل موافقة وزارة الصحة والتنظيم والدفاع المدني والبيئة والأشعة مسارات متوازية تحت سجل قرارات واحد. الأرقام الصريحة في هذا الدليل تُعامل كحدود دنيا؛ أما المتطلبات المرتبطة بالإخلاء والتهوية والتدريع والأجهزة فتُعتمد بالحساب والمخطط المختوم. ويظل شرطا الترخيص النهائي وإذن مباشرة العمل هما بوابة استقبال أول مريض.